



Nuansa
Fajar
Cemerlang



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN NUTRISI



Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.Ns.,M.Kes.
Ns. Tuti Asrianti Utami, S.Kep.,SE.,M.Kep.
Citra Setyo Dwi Andhini, S.Kep.,Ners.,M.Kep.

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN NUTRISI

TIM PENYUSUN:

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.Ns.,M.Kes.

Ns. Tuti Asrianti Utami, S.Kep.,SE.,M.Kep.

Citra Setyo Dwi Andhini, S.Kep.,Ners.,M.Kep.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

**ASUHAN KEPERAWATAN ANAK
DENGAN GANGGUAN NUTRISI**

Penulis:

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.Ns.,M.Kes.
Ns. Tuti Asrianti Utami, S.Kep.,SE.,M.Kep.
Citra Setyo Dwi Andhini, S.Kep.,Ners.,M.Kep.

Desain Cover:

Ivan Zumarano

Tata Letak:

Siti Hartina Fatimah
Achmad Faisal

ISBN: 978-623-09-3098-0

Cetakan Pertama:

Februari 2023

Hak Cipta 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2023

by Penerbit Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

**Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F
Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah
Jakarta Barat**

Website: www.nuansafajarcemerlang.com

Instagram: @bimbel.optimal

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi dapat selesai dan diterbitkan untuk para pembaca khususnya tenaga kesehatan baik di pendidikan maupun di pelayanan. Buku ini disusun untuk memudahkan perawat dalam memahami dasar-dasar asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi yang mencakup 3 bagian yaitu : (1) Asuhan Keperawatan Anak Stunting; (2) Asuhan Keperawatan Anak Kekurangan Energi Protein (KEP); dan (3) Asuhan Keperawatan Anak Obesitas.

Keunggulan buku ini yaitu gaya penulisan yang jelas dan menarik, terdapat konsep teoritis disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami. Buku ini berisi asuhan keperawatan anak dimulai dari pengkajian, masalah/diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan dengan sumber yang terupdate NANDA NOC NIC dan di padukan sumber buku 3S (SDKI, SLKI, SIKI), buku ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian sebagai penerapan *evidence-based practice*.

Penerbitan buku ini dapat diselesaikan dengan baik dengan dukungan penuh dari Optimal dan melibatkan tim penulis dosen keperawatan anak yang berasal dari institusi pendidikan keperawatan di Indonesia. Terima kasih kepada tim penulis dan tim Optimal yang telah memfasilitasi hingga buku ini dapat diterbitkan. Kami menyadari penulisan buku ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami menghargai masukan agar buku ini terus menjadi lebih baik. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan keperawatan anak di Indonesia dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan keperawatan.

Januari, 2023

Penulis

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku asuhan keperawatan anak pada gangguan nutrisi dapat diselesaikan dengan baik. Masalah gizi utama pada anak di Indonesia diantaranya malnutrisi, obesitas, stunting menjadi perhatian khusus bagi tenaga kesehatan termasuk keperawatan dalam menurunkan prevalensi masalah gizi pada anak serta mencegah anak memiliki komplikasi dari masalah gizi tersebut. Salah satu peran perawat anak secara profesional yaitu memberikan asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proses asuhan keperawatan secara komprehensif.

Buku ini disusun untuk memudahkan perawat dalam memahami dasar-dasar asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi yang terdiri dari 3 (tiga) bab, meliputi: (1) Asuhan Keperawatan Anak Stunting; (2) Asuhan Keperawatan Anak Kekurangan Energi Protein (KEP); dan (3) Asuhan Keperawatan Anak Obesitas. Keunggulan buku ini yaitu gaya penulisan yang jelas dan menarik, terdapat konsep teoritis di sajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, asuhan keperawatan yang di mulai dari pengkajian, masalah/diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan dengan sumber yang terupdate NANDA NIC NOC dan di padukan sumber buku 3S (SDKI, SLKI, SIKI), buku ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian sebagai penerapan *evidence-based practice*.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim Optimal yang telah memfasilitasi hingga buku ini dapat diterbitkan. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam buku ini. Kami menghargai masukan agar buku ini terus menjadi lebih baik. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi generasi penerus keperawatan anak di Indonesia. Selamat menggunakan buku ini dan semoga menambah wawasan keilmuan keperawatan anak dalam meningkatkan kualitas Pendidikan dan pelayanan keperawatan.

Januari, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	v
ASUHAN KEPERAWATAN ANAK STUNTING	1
A. Pendahuluan	3
B. Definisi	4
C. Etiologi	4
D. Patofisiologi.....	5
E. Manifestasi Klinis.....	6
F. Komplikasi	7
G. Pemeriksaan Penunjang	7
H. Penatalaksanaan	7
I. Pengkajian	8
J. Diagnosis Keperawatan	11
K. Intervensi Keperawatan.....	12
L. Implementasi.....	17
M. Evaluasi	18
DAFTAR PUSTAKA.....	19
ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN KEKURANGAN ENERGI PROTEIN	21
A. Pendahuluan	23
B. Definisi Kekurangan Energi Protein	24
C. Etiologi	24
D. Patofisiologi.....	25
E. Klasifikasi KEP	25
F. Manifestasi Klinis.....	26
G. Komplikasi	26
H. Pemeriksaan Penunjang	27
I. Penatalaksanaan	27
J. Pengobatan atau Medikemantosa	28
K. Pengkajian Keperawatan	30
K. Analisa Data.....	32
L. Diagnosa Keperawatan	32
M. Intervensi Keperawatan.....	33
N. Implementasi Keperawatan	35
O. Evaluasi Keperawatan.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN OBESITAS	39
A. Definisi	41
B. Etiologi	41
C. Patofisiologi.....	43
D. Manifestasi Klinis.....	44
E. Komplikasi	44
F. Penatalaksanaan	45
G. Pengkajian	47
H. Diagnosis	49
I. Intervensi	51
J. Diagnosa keperawatan : Berat Badan Lebih	52
K. Diagnosa keperawatan : Obesitas	53
L. Diagnosa keperawatan : Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah	54
M. Implementasi.....	56
N. Evaluasi	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	59
BIOGRAFI PENULIS	63
SINOPSIS.....	65

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK STUNTING

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.Ns.,M.Kes.



ASUHAN KEPERAWATAN ANAK STUNTING

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.Ns.,M.Kes.

A. Pendahuluan

Berdasarkan data prevalensi balita stunting oleh WHO, pada tahun 2020 sebanyak 22% atau sekitar 149,2 juta balita di dunia mengalami kejadian stunting (Ruswati et al., 2021). Prevalensi stunting global pada anak di bawah usia 5 tahun telah terbukti menurun secara perlahan, tetapi di banyak negara seperti di Pakistan, prevalensi stunting anak tetap di atas ambang kritis WHO ($\geq 30\%$; sangat tinggi) selama 2 dekade terakhir. Prevalensi stunting pada tahun 2018 sebesar 40%, tertinggi pada anak yang tinggal di perdesaan (43%) dan pada kuintil kekayaan terendah (51%) penduduk nasional (National Nutrition Survey 2018, 2020).

Menurut survey status gizi balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2021, angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% tahun 2021. (Kemenkes R., 2021) Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia lebih baik dibandingkan Myanmar (35%), tetapi masih lebih tinggi dari Vietnam (23%), Malaysia (17%), Thailand (16%), dan Singapura (4%). Meski terlihat ada penurunan angka prevalensi, tetapi stunting dinilai masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena angka prevalensinya yang masih di atas 20%. Oleh karena itu, stunting masih menjadi permasalahan yang serius dan harus segera ditanggulangi agar angka stunting bisa mengalami penurunan dan sesuai dengan anjuran WHO (*World Health Organization*) (Kemen PPPA, 2020).

Prevalensi stunting anak di Indonesia tetap tinggi selama dekade terakhir disebabkan pemberian ASI non eksklusif selama 6 bulan pertama, status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah, kelahiran prematur, panjang lahir pendek, dan tinggi badan serta pendidikan ibu yang rendah merupakan faktor penentu stunting pada anak di Indonesia (Beal, Tumilowicz, Sutrisna, Izwardy, & Neufeld, 2018). Salah satu permasalahan kesehatan di dunia yang menyebabkan kematian anak usia dibawah lima tahun adalah masalah status gizi. Menurut WHO diantara empat puluh lima persen anak di bawah usia 5 tahun meninggal karena kekurangan gizi. (WHO, 2021b). Prevalensi masalah status nutrisi pada anak terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari WHO pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jumlah anak balita yang menderita stunting sebanyak 148,9 juta, dan angka kejadian wasting pada anak dibawah 5 tahun yaitu 49.5 juta, selanjutnya angka anak dibawah 5 tahun yang mengalami kelebihan berat badan sebanyak 40 juta (WHO, 2019). Peningkatan kasus pada tahun 2020 di peroleh lebih dari 149 juta balita diperkirakan mengalami stunting atau terlalu pendek untuk usia mereka, dan 45 juta anak dengan kondisi terlalu kurus (WHO, 2021a).

B. Definisi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun (TNP2K, 2017).

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri anak, pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan stunted (pendek) dan severely stunted (sangat pendek). Z - score untuk kategori pendek adalah 3 SD sampai dengan <-2 SD dan sangat pendek adalah <-3 SD.

Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis dan dapat menimbulkan dampak jangka panjang, antara lain hambatan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif dan mental, kerentanan terhadap penyakit, produktivitas ekonomi rendah, dan kualitas hasil reproduksi rendah. (Kemenkes RI, 2018)

C. Etiologi

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Stunting dapat terjadi sebagai akibat kekurangan gizi terutama pada saat 1000 Hari pertama Kehidupan (HPK). Menurut WHO ada beberapa faktor penyebab terjadinya stunting pada anak yang dibagi menjadi 4 kategori besar:

1. Faktor keluarga dan rumah tangga

Faktor ini mencakup 2 faktor yaitu faktor maternal dan faktor lingkungan rumah. Faktor maternal, dapat disebabkan karena nutrisi yang buruk selama prekonsepsi, kehamilan, dan laktasi. Selain itu juga dipengaruhi perawakan ibu yang pendek, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, IUGR dan persalinan prematur, masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-*Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan), dan pembelajaran dini yang berkualitas. Sedangkan untuk faktor lingkungan rumah berupa stimulasi dan aktivitas anak yang tidak adekuat, perawatan yang kurang, sanitasi dan pasokan air yang tidak adekuat, akses dan ketersediaan pangan yang kurang, alokasi makanan dalam rumah tangga yang tidak sesuai, edukasi pengasuh yang rendah (Rahayu, Yulidasari, Putri, & Anggraini, 2018).

2. *Complementary feeding* yang tidak adekuat

Setelah umur 6 bulan, setiap bayi membutuhkan makanan lunak yang bergizi sering disebut Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Pengenalan dan pemberian MP- ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi/anak. Selain berfungsi untuk mengenalkan

jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

3. Beberapa masalah dalam pemberian ASI

Rendahnya kesadaran Ibu akan pentingnya memberikan ASI pada balitanya dipengaruhi oleh pengetahuan ibu tentang kesehatan dan sosio-kultural, terbatasnya petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan, tradisi daerah berpengaruh terhadap pemberian makanan pendamping ASI yang terlalu dini, dan tidak lancarnya ASI setelah melahirkan. Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi delayed initiation, tidak menerapkan ASI eksklusif, dan penghentian dini konsumsi ASI. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif.

4. Infeksi

Penyebab langsung malnutrisi adalah diet yang tidak adekuat dan penyakit. Manifestasi malnutrisi ini disebabkan oleh perbedaan antara jumlah zat gizi yang diserap dari makanan dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari terlalu sedikit mengkonsumsi makanan atau mengalami infeksi, yang meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat gizi, mengurangi nafsu makan, atau mempengaruhi penyerapan zat gizi di usus. Kenyataannya, malnutrisi dan infeksi sering terjadi pada saat bersamaan. Malnutrisi dapat meningkatkan risiko infeksi, sedangkan infeksi dapat menyebabkan malnutrisi yang mengarahkan ke lingkaran setan. Anak kurang gizi, yang daya tahan terhadap penyakitnya rendah, jatuh sakit dan akan menjadi semakin kurang gizi, sehingga mengurangi kapasitasnya untuk melawan penyakit dan sebagainya. Ini disebut juga infection malnutrition.

D. Patofisiologi

Proses pertumbuhan di bawah kendali genetik dan pengaruh lingkungan, pada waktu tertentu selama periode pertumbuhan. Pada masa konsepsi, terdapat *blueprint* (cetak biru) genetik yang mencakup potensi untuk mencapai ukuran dan bentuk dewasa tertentu. Lingkungan mengubah potensi ini. Ketika lingkungan netral, tidak memberikan pengaruh negatif pada proses pertumbuhan, potensi genetik dapat sepenuhnya diwujudkan. Namun demikian kemampuan pengaruh lingkungan untuk mengubah potensi genetik tergantung pada banyak faktor, termasuk waktu di mana mereka terjadi; kekuatan, durasi, frekuensi kemunculannya; dan usia serta jenis kelamin anak.

Dalam hal pertumbuhan dan perkembangan manusia, kelenjar endokrin yang berperan penting adalah kelenjar hipofisis, yang terletak di bawah dan sedikit di depan hipotalamus. Suplai darah yang kaya dalam infundibulum, yang menghubungkan dua kelenjar, membawa hormon pengatur dari hipotalamus ke kelenjar hipofisis. Hipofisis memiliki lobus anterior dan posterior. Lobus anterior, atau adenohipofisis, melepaskan hormon utama yang mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan manusia yaitu hormon pertumbuhan (Growth Hormone/GH), hormon perangsang tiroid (Thyroid Stimulating Hormone (TSH), prolaktin, gonadotrofin (Luteinizing dan hormon perangsang folikel), dan hormon adrenocorticotropik (ACTH) .

Pertumbuhan normal tidak hanya bergantung pada kecukupan hormon pertumbuhan tetapi merupakan hasil yang kompleks antara sistem saraf dan sistem endokrin. Hormon jarang bertindak sendiri tetapi membutuhkan kolaborasi atau intervensi hormon lain untuk mencapai efek penuh. Hormon pertumbuhan menyebabkan pelepasan faktor pertumbuhan mirip insulin (Insulin like Growth Factor 1 (IGF-1)) dari hati. IGF-1 secara langsung mempengaruhi serat otot rangka dan sel-sel tulang rawan di tulang panjang untuk meningkatkan tingkat penyerapan asam amino dan memasukkannya ke dalam protein baru, sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan linear selama masa bayi dan masa kecil. Pada masa remaja, percepatan pertumbuhan remaja terjadi karena kolaborasi dengan hormon gonad, yaitu testosteron pada anak laki-laki, dan estrogen pada anak perempuan.

Ada banyak bukti dari penelitian tentang anak-anak dengan perawakan pendek yang tidak normal terjadi akibat faktor lingkungan yang mengganggu sistem endokrin, menyebabkan pengurangan dalam pelepasan hormon pertumbuhan. Namun, hormon lain juga terpengaruh membuat penyebab gangguan pertumbuhan menjadi kompleks (Candra, 2020).

E. Manifestasi Klinis

Menurut Kemenkes (2018), balita *Stunting* dapat dikenali ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pertumbuhan melambat, batas bawah kecepatan tumbuh adalah 5 cm/ tahun
2. Kecepatan tumbuh tinggi badan < 4cm/tahun kemungkinan ada kelainan hormonal
3. Umur tulang (*bone age*) bosa normal atau terlambat untuk umurnya
4. Tanda pubertas terlambat
5. Performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar
6. Pertumbuhan gigi terlambat
7. Usia 8 – 10 tahun anak akan lebih pendiam
8. Tidak banyak melakukan *eye contact*
9. Pertumbuhan melambat
10. Wajah tampak lebih muda dari usianya

F. Komplikasi

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut dapat berupa jangka pendek dan jangka panjang.

1. Jangka pendek

Dampak yang ditimbulkan adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh.

2. Jangka panjang

Dampak yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Kemenkes, 2017).

G. Pemeriksaan Penunjang

Untuk menentukan stunting pada anak dilakukan dengan cara pengukuran. Antropometri, atau pengukuran parameter tubuh, membantu diagnosis malnutrisi dan obesitas serta stunting. (Warrier, Krishan, Shedge, & Tanuj Kanchan, 2022). Pengukuran tinggi badan menurut umur dilakukan pada anak umur diatas dua tahun. Antropometri merupakan ukuran dari tubuh sedangkan antropometri gizi adalah jenis pengukuran dari beberapa bentuk tubuh dan komposisi tubuh menurut umur dan tingkatan gizi, yang digunakan untuk mengetahui ketidakseimbangan energi dan protein. Antropometri dilakukan untuk pengukuran pertumbuhan tinggi badan dan berat badan.

Indikator antropometrik seperti tinggi badan menurut umur adalah penting dalam mengevaluasi kesehatan dan status gizi anak-anak pada wilayah dengan banyak masalah gizi buruk. Dalam menentukan klasifikasi gizi kurang dengan stunting sesuai dengan “Cut off point”, dengan penilaian Z-score, dan pengukuran pada anak balita berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U) standar baku WHO-NCHS.

Berikut Klasifikasi status gizi stunting berdasarkan indikator TB/U (Kemenkes 2020):

- Sangat pendek : Z-score < -3,0
- Pendek : Z-score < -2,0 s.d Z-score ≥ -3,0

H. Penatalaksanaan

Salah satu cara mencegah stunting adalah pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Upaya ini sangat diperlukan mengingat stunting akan

berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dan status kesehatan pada saat dewasa.

Adapun penanganan stunting yang dapat dilakukan yaitu dapat melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada sasaran 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak sampai berusia 6 tahun.

- Intervensi Gizi Spesifik
 1. Intervensi yang ditujukan kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan
 2. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan
 3. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek
- Intervensi Gizi Sensitif
 1. Intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan
 2. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk sasaran Hari Pertama Kehidupan.

I. Pengkajian

Pengkajian nutrisi merupakan langkah awal yang penting dalam asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan preventif. Pengkajian nutrisi membantu dalam mengidentifikasi kebiasaan makan, kesalahpahaman, dan gejala-gejala yang dapat memberi petunjuk adanya masalah nutrisi. Karena perawat sering berhubungan dengan orang tua dan anak, perawat sering kali dapat memengaruhi praktik diet klien (Engel, 2009).

1. Pengukuran PB/TB Menurut Umur Anak Usia 0-60 bulan
Pengukuran ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (*stunted*) dengan *Z Score* (<-3 SD) atau sangat pendek (*severely stunted*) dengan *Z Score* (-3 SD sd <-2 SD) yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit.
2. Pengkajian Kebiasaan Makan
Pengkajian kebiasaan makan membutuhkan sensitivitas perawat. kebiasaan makan merupakan hal yang sangat pribadi dan dipengaruhi budaya serta dapat dikaji lebih cermat jika hubungan sudah terjalin. Rasa bersalah, ketakutan, dan keinginan untuk memberi respons yang benar dapat mengubah akurasi pengkajian.
3. Pengkajian umum
 - a. Apakah anak Anda mempunyai diet khusus?
 - b. Apakah ada dugaan atau diketahui alergi terhadap makanan?
 - c. Uraikan diet khas anak Anda selama 24 jam (apa yang dimakan anak setiap kali makan dan di antara makan)

- d. Apakah anak Anda mengalami penurunan atau penambahan berat badan akhir-akhir ini?
 - e. Apakah terdapat pengaruh budaya, etnis, atau agama yang memengaruhi diet anak Anda? Jelaskan
 - f. Apakah Anda mempunyai masalah?
4. Pengkajian kebiasaan pemberian makan pada bayi
- a. Berapa pertambahan berat badan Anda (ibu) selama kehamilan?
 - b. Berapa berat badan lahir bayi Anda? Pada usia berapa mencapai dua kali berat badan lahir?
 - c. Suplemen vitamin apa yang diterima bayi Anda?
 - d. Apakah bayi Anda menerima cairan ekstra seperti jus atau air?
 - e. Pada usia berapakah Anda mulai memberi sereal, sayuran, buah-buahan, daging (atau sumber protein lainnya), makan di meja, dan makanan yang dapat dipegang?
 - f. Apakah bayi Anda sering mengeluarkan air ludah? Seperti apa kotoran (feses) bayi Anda?
 - g. Apakah bayi Anda mempunyai masalah dengan pemberian makan (sebagai contoh, kelelahan, daya isap buruk, regurgitasi, kolik, iritabilitas, ruam, diare)?
 - h. Bayi yang minum ASI
 - 1) Berapa lama bayi Anda menyusui dalam satu waktu?
 - 2) Apakah Anda memberi ASI selang-seling?
 - 3) Bagaimana Anda mengetahui bahwa bayi Anda lapar? Kenyang?
 - 4) Ceritakan pola eliminasi dan pola tidur bayi Anda
 - 5) Ceritakan kebiasaan diet Anda sehari-hari
 - 6) Apakah Anda mempunyai masalah yang berhubungan dengan menyusui?
 - i. Bayi yang minum susu formula
 - 1) Apa jenis susu formula yang diminum bayi Anda?
 - 2) Bagaimana Anda menyiapkan susu formula tersebut?
 - 3) Apa jenis botol yang digunakan bayi Anda?
 - 4) Berapa banyak atau ml susu formula yang bayi Anda minum dalam sehari?
 - 5) Apakah Anda menyangga atau menggendong bayi Anda selagi memberi susu?
 - 6) Apakah Anda mempunyai masalah yang berhubungan dengan pemberian susu dengan botol?
 - j. Pengkajian kebiasaan pemberian makan pada Toddler, Pra-sekolah, dan Sekolah
 - 1) Makanan apa yang lebih disukai anak Anda? Tidak disukai?

- 2) Apakah anak suka kudapan? Jika ya, kapan? Makanan apa yang diberikan sebagai kudapan? Kapan makanan yang manis dimakan?
- 3) Bantuan apa yang diperlukan anak Anda untuk makan?

5. Pengkajian Tanda – Tanda Fisik Kekurangan Gizi

Tabel 1 Pengkajian Tanda-tanda Kekurangan Nutrisi

Area Tubuh	Tanda-Tanda Kekurangan Nutrisi
Pertumbuhan umum	• Tinggi badan, berat badan, lingkar kepala di bawah atau di atas persetil ke-5 dan ke-95 • Keterlambatan kematangan seksual
Kulit	• Kekeringan • Pigmentasi kemerahan yang membesar (dermatosis pellagra) • Hierpigmentasi • Edema • Turgor kulit jelek • Petekia • Penyembuhan luka lambat • Jaringan subkutan berkurang • Pucat
Rambut	• Kusam, kering, tipis, rapuh, jarang, mudah tercabut • Alopesia
Kepala	• Tengkorak datar, tulang frontal menonjol • Penyatuan sutura lambat • Benjolan keras, nyeri tekan di daerah oksipital • Sakit kepala
Leher	• Kelenjar tiroid membesar, jelas pada inspeksi
Mata	• Kornea lunak, pudar; bintik putih atau abu-abu pada kornea (bintik Bitot) • Membran pucat • Panas, gatal, fotopobia • Buta senja • Kemerahan, belahan pada sudut-sudut mata
Hidung	• Pecah-pecah, iritasi pada sudut hidung
Bibir	• Belahan sudut, kemerahan dan edema
Lidah	• Kepucatan • Merah, bengkak, lecet • Berwarna magenta • Pengecapan berkurang
Gusi	• Seperti spon, mudah berdarah, turun
Gigi	• Email burik (<i>mottled enamel</i>), noda coklat, berlubang • Email rusak • Karies
Sistem Kardiovaskular	• Palpitasi • Denyut jantung cepat • Aritmia

	• Tekanan darah tinggi • Penurunan tekanan darah
Sistem pencernaan	• Konstipasi • Diare
Sistem muskuloskeletal	• Otot atropi, edema dependen • Lutut tak bisa bergerak, kaki bengkok, pembesaran epifisis • Perdarahan dalam sendi, nyeri • Bintik-bintik pada tulang iga
Sistem neurologis	• Lesu, iritabilitas, letargi • Tetani • Konvulsi • Tidak kokoh, baal pada tangan dan kaki • Refleks berkurang

J. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan merupakan suatu pernyataan klinis terkait kondisi individu, keluarga atau masyarakat yang merupakan akibat dari masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosis keperawatan ini menjadi landasan dan acuan dalam menyusun rencana tindakan asuhan keperawatan (Olfah & Ghofur, 2016). Menurut Nanda dan SDKI terdapat beberapa diagnosis keperawatan yang lazim muncul pada masalah *stunting* yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan Nutrisi: Kurang dari Kebutuhan Tubuh (NANDA, 2021)
2. Ketidakefektifan Dinamika Makan Anak (NANDA, 2021)
3. Ketidakefektifan Dinamika Pemberian Makan Bayi (NANDA, 2021)
4. Risiko Kerusakan Integritas Kulit (NANDA, 2021)
5. Risiko Infeksi (NANDA, 2021)
6. Defisit Perawatan Diri: Makan (NANDA, 2021)
7. Defisien Pengetahuan (NANDA, 2021)
8. Gangguan Tumbuh Kembang (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)
9. Risiko Gangguan Pertumbuhan (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017)

K. Intervensi Keperawatan

Intervensi atau perencanaan keperawatan merupakan suatu rangkaian kegiatan penentuan langkah-langkah untuk mengatasi diagnosis atau masalah keperawatan, merumuskan tujuan, rencana tindakan dan penilaian asuhan keperawatan pada pasien berdasarkan hasil analisis data dan diagnosis keperawatan yang telah ditegakkan berdasarkan hasil pengkajian (Olfah & Ghofur, 2016). Adapun intervensi keperawatan yang dapat dilakukan pada anak dengan masalah stunting sebagai berikut:

No.	Diagnosis/Masalah Keperawatan	Luaran	Intervensi
1.	Ketidakseimbangan Nutrisi: Kurang dari Kebutuhan Tubuh Faktor Yang Berhubungan: - Keengganan pada makanan - Kurang suplai makanan - Kurang minat pada makanan - Kurang pengetahuan tentang kebutuhan nutrisi - Ketidacukupan produksi air susu ibu (ASI) Batasan Karakteristik: - Asupan makanan kurang dari <i>recommended daily allowance</i> (RDA) - Kurang peningkatan tinggi badan untuk usia dan gender - Penambahan berat badan neonatus <30 gram per hari - Membran mukosa pucat - Penurunan berat badan dengan asupan makan adekuat Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik.	Setelah dilakukan intervensi keperawatan maka diharapkan status nutrisi dapat membaik dengan kriteria hasil: - Asupan gizi tidak menyimpang dari rentang normal - Asupan makanan tidak menyimpang dari rentang normal - Risiko berat badan/tinggi badan tidak menyimpang dari rentang normal - Nafsu makan meningkat - Porsi makanan dari yang tidak habis menjadi habis	Manajemen Nutrisi Observasi: - Identifikasi status nutrisi - Identifikasi makanan yang disukai - Monitor asupan makanan - Monitor berat badan Terapeutik: - Lakukan oral hygiene jika perlu - Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi - Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein - Berikan suplemen makan, jika perlu edukasi - Anjurkan diet yang diprogramkan
2.	Ketidakefektifan Dinamika Makan Anak	Setelah dilakukan intervensi keperawatan	Edukasi Pemberian Makanan pada Anak

	Faktor Yang berhubungan: <i>Kebiasaan Makan</i> - Pola kebiasaan makan abnormal - Kurang pilihan waktu makan - Waktu makan penuh stress - Pola makan tidak dapat diprediksi - Makan kudapan diantara makan tidak terstruktur <i>Parental</i> - Anoreksia - Ketidakmampuan mendukung pola makan sehat - Kurang percaya diri pada anak untuk bertumbuh sesuai tahapnya Batasan karakteristik: - Menolak makan - Sering makan makanan cepat saji - Sering makan makanan dengan kualitas rendah - Kurang nafsu makan - Kurang makan Definisi: Perubahan sikap, perilaku, dan pengaruh pada pola makan anak yang mengakibatkan gangguan Kesehatan nutrisi.	maka perilaku patuh: diet yang sehat dapat dilakukan secara konsisten dengan kriteria hasil: - Menggunakan panduan nutrisi yang direkomendasikan untuk merencanakan menu makanan dilakukan secara konsisten - Memilih makanan sesuai dengan panduan nutrisi yang direkomendasikan dilakukan secara konsisten - Mempertahankan hidrasi dilakukan secara konsisten - Memilih makanan yang mengandung kalsium untuk memenuhi kebutuhan tubuh.	<i>Obersevasi</i> - Identifikasi pemahaman orang tua/keluarga tentang pemilihan jenis makanan sehat yang sesuai dengan usia <i>Edukasi</i> - Jelaskan variasi menu seimbang - Jelaskan pentingnya lingkungan yang kondusif pada saat pemberian makan pada anak - Ajarkan orang tua mengidentifikasi makanan yang disukai dan tidak disukai anak - Ajarkan orang tua mengidentifikasi makanan dan kebiasaan makan anak - Ajarkan orang tua menyajikan makanan secara kreatif dan menarik
3.	Ketidakefektifan Dinamika Pemberian Makan Bayi Faktor yang berhubungan: - Kurang percaya diri anak untuk mengembangkan kebiasaan makan sehat - Kurang percaya diri anak untuk bertumbuh sesuai tahapnya - Kurang pengetahuan tentang metode yang tepat memberi makan bayi pada setiap perkembangan	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan pemberian makan melalui botol: bayi sepenuhnya adekuat dengan kriteria hasil: - Toleransi makan sepenuhnya adekuat - Penambahan berat bada sesuai usia sepenuhnya adekuat - Kepuasan setelah makan sepenuhnya adekuat	Edukasi Nutrisi Bayi <i>Observasi</i> - Identifikasi kesiapan dan kemampuan ibu atau pengasuh menyediakan nutrisi. <i>Edukasi</i> - Jelaskan tanda-tanda awal rasa lapar (bayi gelisah, membuka mulut, menggeleng-gelengkan kepala, menjulurkan lidah, mengisap jari atau tangan)

	- Kurang pengetahuan tentang tahap perkembangan bayi - Kurang pengetahuan orang tua tentang tanggung jawab memberi makan bayi - Pengaruh media pada pengetahuan tentang makanan tidak sehat tinggi kalori Batasan Karakteristik: - Menolak makan - Kurang nafsu makan - Kurang makan - Transisi ke makanan padat tidak tepat Definisi: Perubahan perilaku orang tua dalam memberi makan yang mengakibatkan pola makan berlebih atau kurang		- Ajarkan cara memilih makanan sesuai dengan suai bayi - Ajarkan cara mengatur frekuensi makan sesuai usia bayi - Anjurkan tetap memberika ASI saat bayi sakit.
4.	Risiko Kerusakan Integritas Kulit Faktor risiko: - Indeks massa tubuh di bawah rentang normal usia dan gender - Kurang pengetahuan tentang mempertahankan integritas kulit - Kurang pengetahuan pemberi asuhan tentang melindungi integritas kulit - Malnutrisi Definisi: Rentan pada perubahan pada epidermis dan atau dermis, yang dapat mengganggu Kesehatan	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan keluarga mampu merawat klien agar risiko gangguan integritas kulit menurun dengan kriteria hasil: - Elastisitas meningkat - Hidrasi meningkat - Tekstur kulit meningkat	Perawatan Integritas Kulit <i>Observasi</i> - Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (mis. Perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrem, penurunan mobilitas) <i>Terapeutik</i> - Bersihkan perineal dengan air hangat, terutama selama periode diare Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering - Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit sensitive - Hindari produk berbahan dasar alcohol pada kulit kering <i>Edukasi</i>

			- Anjurkan menggunakan pelembab (mis. Lotion, serum) - Anjurkan minum air yang cukup - Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi - Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur
5.	Risiko Infeksi Faktor Risiko: - Kerusakan integritas kulit - Kurang mentaati rekomendasi Kesehatan masyarakat - Kurang hygiene - Kurang literasi Kesehatan - Kurang kebiasaan hygiene oral - Malnutrisi Definisi: Rentan pada invasi dan multiplikasi organisme patogenik yang dapat mengganggu Kesehatan.	Setelah dilakukan intervensi keperawatan 3x24 jam diharapkan keluarga mampu merawat klien agar risiko infeksi dapat menurun dengan kriteria hasil: - Kebersihan tangan meningkat - Kebersihan badan meningkat - Nafsu makan meningkat	Pencegahan Infeksi <i>Observasi</i> - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <i>Edukasi</i> - Jelaskan tanda dan gejala infeksi - Ajarkan meningkatkan asupan nutrisi

6.	Defisit Perawatan Diri: Makan Faktor yang berhubungan: - Penurunan motivasi - Halangan lingkungan Batasan karakteristik: - Kesulitan memasukkan makanan ke mulut - Kesulitan mengunyah makanan - Kesulitan menghabiskan makanan secara mandiri - Kesulitan memakan makanan dalam cara yang dapat diterima - Kesulitan menelan makanan dalam jumlah memadai Definisi: Ketidakmampuan makan secara mandiri	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan keluarga mampu merawat klien agar deficit perawatan diri: makan meningkat: Luaran Utama: Perawatan Diri: Makan - Memasukkan makanan kemulut dengan peralatan (makan) tidak terganggu - Mengunyah makanan tidak terganggu - Menghabiskan makanan tidak terganggu - Menelan makanan dan minuman tidak terganggu	Dukungan perawatan diri: makan <i>Observasi</i> - Identifikasi diet yang dianjurkan - Monitor kemampuan menelan <i>Terapeutik</i> - Siapkan makanan dengan suhu yang meningkatkan nafsu makan - Sediakan makanan dan minuman yang disukai
7.	Defisien Pengetahuan Faktor yang berhubungan: - Kurang akses ke sumber - Kurang kesadaran tentang sumber - Kurang komitmen pada pembelajaran - Kurang informasi - Kurang partisipasi dalam rencana perawatan Batasan Karakteristik: - Ketidakakuratan mengikuti perintah - Perilaku tidak tepat Definisi: Ketiadaan informasi kognitif yang berkaitan dengan topik tertentu, atau penguasaannya.	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan keluarga mampu mengenal masalah Kesehatan klien agar tingkat pengetahuan membaik dengan kriteria hasil: - Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat - Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat	Edukasi Kesehatan <i>Observasi</i> - Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi <i>Terapeutik</i> - Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan - Berikan kesempatan bertanya <i>Edukasi</i> - Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

8.	Gangguan Tumbuh Kembang Gejala Tanda Mayor: <i>Objektif</i> - Pertumbuhan fisik terganggu - Tidak mampu melakukan keterampilan atau perilaku khas sesuai usia (fisik, Bahasa, motoric, psikososial) Gejala Tanda Minor <i>Objektif</i> - Nafsu makan menurun - Lesu Definisi: Kondisi individu mengalami gangguan bertumbuh dan berkembang sesuai kelompok usia	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil: - Keterampilan/perilaku sesuai dengan usia meningkat - Lingkar kepala sesuai usia meningkat	Perawatan Perkembangan Anak <i>Observasi</i> - Identifikasi pencapaian tugas perkembangan anak <i>Terapeutik</i> - Pertahankan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal - Pertahankan kenyamanan anak <i>Edukasi</i> - Jelaskan orang tua dan atau pengasuh tentang <i>milestone</i> perkembangan anak dan perilaku anak
9.	Risiko Gangguan Pertumbuhan Faktor Risiko: - Ketidakadekuatan nutrisi - Ketidakadekuatan perawatan prenatal - Keterlambatan perawatan prenatal - Prematuritas - Usia hamil di bawah 15 tahun - usia hamil di atas 35 tahun Definisi: Berisiko mengalami gangguan untuk berkembang sesuai dengan kelompok usianya.	Setelah dilakukan intervensi keperawatan diharapkan status pertumbuhan dapat membaik dengan kriteria hasil: - Berat badan sesuai dengan usia meningkat - Tinggi badan sesuai dengan usia meningkat - Indeks massa tubuh meningkat - Asupan nutrisi meningkat	Manajemen Nutrisi <i>Observasi</i> - Identifikasi status nutrisi - Identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrient - Monitor berat badan <i>Terapeutik</i> - Sajikan makanan secara menarik - Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein

L. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh perawat dengan tujuan membantu pasien dari masalah status Kesehatan yang dihadapi menuju ke status Kesehatan yang lebih baik sesuai dengan intervensi yang telah disusun sebelumnya (Olfah & Ghofur, 2016). Adapun hasil penelitian yang dapat diimplementasikan pada anak dengan stunting:

1. Pemberian makanan tambahan udang rebon

Dilakukan intervensi berupa pemberian makanan tambahan berupa udang rebon selama 90 hari. Tinggi badan anak dinilai pada awal dan tindak lanjut bulanan hingga akhir pada hari ke-90. Hasilnya berupa pertambahan tinggi badan anak yang mendapatkan makanan tambahan berupa udang rebon (3,94 cm) lebih besar daripada anak yang tidak mendapatkan produk rebon (2,92 cm). Bahan makanan tambahan berbahan dasar udang rebon bermanfaat untuk menambah tinggi badan pada anak stunting (Anton et al., 2022).

2. Pemberian makanan tambahan Nugget Ikan Lemuru

Pemberian makanan selingan berbahan ikan lemuru setiap hari selama 21 hari pada anak yang stunting dengan usia 13-36 bulan. Monitoring dan evaluasi dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan cara wawancara terhadap makanan yang dikonsumsi anak. Penelitian ini memberikan hasil bahwa sebelum diberikan intervensi diketahui rata-rata Z-Score TB/U sebesar -2,46. Setelah dilakukan pemberian intervensi maka diperoleh hasil rata-rata Z-score TB/U sebesar -2,25. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemberian makanan tambahan akan menaikkan tinggi badan anak yang mengalami stunting, percepatan pertambahan tinggi badan dalam penelitian ini karena makanan tambahan berbahan ikan yang diberikan mengandung protein, kalsium dan zink yang tinggi (Martony et al., 2020)

M. Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses keperawatan yang merupakan kegiatan sengaja dan terus-menerus yang melibatkan klien atau pasien dengan perawat dan anggota tim kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan ini menjadi tahap terakhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna untuk menilai apakah kriteria hasil yang telah ditentukan pada luaran keperawatan tercapai atau tidak tercapai setelah dilakukan tindakan keperawatan (Olfah & Ghofur, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, S. S., Bukhari, A., Baso, A. J. A., & Ayu, K. (2022). *Effect of Rebon Shrimp-Based Supplementary Feeding on Height of Stunted Children*. 5(24), 236–241.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. alfnuM. (2018). A review of child stunting determinants in Indonesia. *Maternal and Child Nutrition*, 14(4), 1–10. <https://doi.org/10.1111/mcn.12617>
- Butcher, H. K., Bulechek, G. M., Dochterman, J. M., & Wagner, C. M. (2018). *Nursing Intervention Classification*. (I. Nurjannah, Trans.) Yogyakarta: Mocomedia.
- Candra, A. (2020). Patofisiologi Stunting. *JNH (Journal of Nutrition and Health)*, 8(2), 27–31.
- Engel, J. (2009). *Seri Pedoman Praktis Pengkajian Pediatrik*, Edisi 4. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Kemen PPPA. (2020). *PANDEMI COVID-19, STUNTING MASIH MENJADI TANTANGAN BESAR*. Retrieved 12 21, 2022, from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2929/pandemi-covid-19-stuntingmasih>
- Kemenkes RI. (2017). *Buku Saku Desa dalam penanganan Stunting*. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Kemenkes RI. (2018). *Buletin Warta Kesmas Cegah Stunting itu Penting*. Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2021). *Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2021 Sebagai Modal Menuju Generasi Emas Indonesia 2045*. Retrieved Desember 27, 2022, from Kemenkes RI: <https://www.kemkes.go.id/article/view/21122800001/penurunan-prevalensi-stunting-tahun-2021-sebagai-modal-menuju-generasi-emas-indonesia-2045.html>
- Kemenkes RI. (2022). *Buku Bagan Manajemen Terpadu Balita Sakit*. Kemenkes RI
- Martony, O., Lestrina, D., & Amri, Z. (2020). Pemberdayaan Ibu untuk Perbaikan Pola Konsumsi Ikan terhadap Peningkatan Asupan Protein, Kalsium, Zink dan Z-Score Tinggi Badan Menurut Umur pada Anak Stunting. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3(2), 672–686. <https://doi.org/10.31539/jks.v3i2.1188>
- Moorhead, S., Swanson, E., Johnson, M., & Maas, M. L. (2018). *Klasifikasi Luaran Keperawatan / Nursing Outcomes Classification (NOC) Pengukuran Outcome Kesehatan*. (I. Nurjannah, Trans.) Yogyakarta: Mocomedia.
- National Nutrition Survey 2018. (2020). Government of Pakistan, Nutrition Wing, Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination; and UNICEF. *Government of Pakistan and UNICEF*, 1. Retrieved from <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Olfah, Y., & Ghofur, A. (2016). *Dokumentasi Keperawatan*. Jakarta Selatan: Pusdik SDM Kesehatan Kemenkes RI.

- Rahayu, A., Yulidasari, F., Putri, A. O., & Anggraini, L. (2018). *Study Guide - Stunting dan Upaya Pencegahannya. Buku stunting dan upaya pencegahannya*.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia (PPNI).
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia (PPNI)
- Tim Pokja SLKI PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia (PPNI)
- TNP2K, T. N. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta Pusat: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Warrier, V., Krishan, K., Shedge, R., & Tanuj Kanchan. (2022). *Height Assessment*. Treasure Island: star pearls.
- WHO. (2019). World hunger is still not going down after three years and obesity is still growing. *Who*, 1.
- WHO. (2021a). UN report: Pandemic year marked by spike in world hunger Africa posting biggest jump. World at critical juncture, must act now for 2030 turnaround. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-31913/v1>
- WHO. (2021). *WHO accelerates work on nutrition targets with new commitments*. <https://doi.org/10.7591/cornell/9781501758898.003.0006>

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN KEKURANGAN ENERGI PROTEIN

Ns. Tuti Asrianti Utami, S.Kep.,SE.,M.Kep.



ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN KEKURANGAN ENERGI PROTEIN

Ns. Tuti Asrianti Utami, S.Kep.,SE.,M.Kep.

A. Pendahuluan

Status gizi didefinisikan sebagai keadaan seimbang antara asupan zat gizi yang dikonsumsi dengan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh (Putri, N. E., Andarini, M. Y., & Achmad, 2021). Zat gizi meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Asupan zat gizi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh akan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dengan konsumsi makanan yang tidak adekuat (kurang gizi) sehingga menyebabkan malnutrisi (Nurwijayanti, 2019). Malnutrisi energi-protein, misalnya merupakan sebuah peran utama dari semua kematian anak dibawah usia 5 tahun setiap tahunnya di negara-negara berkembang. Kurang Energi Protein (KEP) adalah seseorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan atau gangguan penyakit tertentu (Kemenkes RI, 2020).

United Nations Children's Fund (UNICEF) mencatat balita yang mengalami *stunting* sebanyak 22,2%, *wasting* sebanyak 7,5%, dan *overweight* sebanyak 5,6% (WHO, UNICEF, 2020). Pada tahun 2017, persentase *underweight* di dunia turun menjadi 13,5% (*The World Bank*, 2018). Masalah gizi pada balita paling banyak ditemukan di Afrika dan Asia. Di Asia Timur dan Pasifik. Tahun 2017 di dapatkan bahwa jumlah balita *underweight* sebanyak 5,9% (*The World Bank*, 2018). Jumlah balita yang mengalami *stunting* sebanyak 9,0%, *wasting* sebanyak 3,0%, dan *overweight* sebanyak 5,7% (UNICEF, 2018).

Di Indonesia masalah gizi masih cukup tinggi berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG). Provinsi di Indonesia dengan presentase masalah kekurangan gizi tertinggi tahun 2021 berdasarkan laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebanyak 24,4% atau 1 dari 4 anak balita Indonesia mengalami *stunting* akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Provinsi dengan angka *stunting* tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,80%), Aceh (33,20%), Nusa Tenggara Barat (31,40%), Sulawesi Tenggara (30,20%) dan Kalimantan Selatan (30%).

World Health Organization (WHO), 2017 menjelaskan bahwa sekitar 5,6 juta anak balita meninggal pada tahun 2016. Balita yang mengalami kekurangan gizi lebih rentan terkena infeksi, serta memperlambat pemulihan kondisi kesehatan pada balita (UNICEF, 2018). Status gizi balita dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya karena penyakit diare merupakan penyebab utama dari masalah kekurangan gizi (Hockenberry et al., 2017).

Faktor lainnya adalah pemberian susu formula (kondisi sanitasi lingkungan yang buruk), pengetahuan yang tidak memadai tentang pola asuh anak, faktor ekonomi, dan politik, kondisi iklim, jenis makanan yang dikonsumsi berdasarkan kurangnya makanan yang adekuat (Hockenberry & Wilson, 2015). Selain itu, faktor yang mempengaruhi status gizi balita meliputi usia ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, riwayat penyakit, riwayat pemberian ASI eksklusif, riwayat pemberian MP ASI (Handayani, 2017). Faktor yang mempengaruhi status gizi balita adalah rendahnya pendapatan orang tua sehingga tidak mampu memberikan makanan yang bergizi dan kurangnya pengetahuan ibu terkait pemberian nutrisi yang meliputi pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif dan jenis makanan pendamping ASI (MP-ASI) (Pawenrusi, 2016).

Perawat mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan kasus gizi buruk melalui upaya promotif melalui pelayanan primer dapat memberikan penyuluhan kepada kader-kader dan ibu balita, menyediakan media KIE seperti poster, leaflet, lembar balik, *booklet*, *food model* tentang pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI serta makanan bergizi untuk balita. Upaya preventif meliputi penimbangan berat badan, pengukuran lingkaran lengan dan tinggi badan yang dilakukan sebulan sekali di posyandu dan pola asuh anak yang benar serta lainnya (Kusumawardani et al, 2020). Buku ini semoga dapat membantu bagaimana dalam memberikan asuhan Keperawatan anak yang mengalami masalah Kekurangan Energi Protein.

B. Definisi Kekurangan Energi Protein

Kekurangan Energi Protein (KEP) merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari atau disebabkan oleh gangguan penyakit tertentu, sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi (Kemenkes RI, 2014). KEP sendiri lebih sering dijumpai pada anak prasekolah (Nurhayati & Nugroho, 2021).

C. Etiologi

KEP dapat disebabkan karena :

1. Penyebab langsung dari KEP adalah defisiensi kalori maupun protein dengan berbagai gejala-gejala yang disebabkan oleh penyakit infeksi.
2. Penyebab tidak langsung KEP sangat banyak, sehingga penyakit ini sering disebut juga dengan kausa multifaktorial. Salah satu penyebabnya adalah keterkaitan dengan waktu pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan makanan tambahan setelah disapih (Khumaedi, 1989).

Termasuk diantaranya adalah: a) Zat-zat gizi yang terkandung di dalam makanan, b) Daya beli keluarga, meliputi penghasilan, harga bahan makanan dan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan lain selain makanan; c)

Kepercayaan ibu tentang makanan serta kesehatan; d) Ada atau tidaknya pemeliharaan kesehatan termasuk kebersihan; dan e) Fenomena sosial dan keadaan lingkungan (Levinson, 1979 dalam Lismartina, 2000).

D. Patofisiologi

Asupan makanan yang kadar proteinnya kurang dari kebutuhan tubuh, mengakibatkan kekurangan asam amino esensial yang diperlukan dalam pertumbuhan dan perbaikan sel. Apabila kebutuhan zat gizi akan protein tidak tercapai maka tubuh akan menggunakan cadangan makanan yang ada, dimulai dengan pembakaran cadangan karbohidrat kemudian cadangan lemak serta protein dengan melalui proses katabolik. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu lama, cadangan itu akan habis dan akan menyebabkan kelainan pada jaringan, dan proses 8 selanjutnya dalam tubuh akan menunjukkan manifestasi Kurang Energi Protein (KEP) berat yang biasa disebut kwashiorkor (kekurangan protein) ataupun marasmus (kekurangan energi).

Pedoman Tata Laksana KEP pada anak di puskesmas dan di rumah tangga, KEP berdasarkan gejala klinis ada 3 tipe yaitu KEP ringan, sedang dan berat (gizi buruk). Untuk KEP ringan dan sedang, gejala klinis yang ditemukan hanya anak tampak kurus. Gejala klinis KEP berat/gizi buruk secara garis besar dapat dibedakan sebagai marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor (Kemenkes RI, 2021).

E. Klasifikasi KEP

Umumnya klasifikasi KEP berdasarkan pengukuran antropometri Penentuan status gizi berdasarkan nilai Z-Score yang berdasarkan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan usia. Pengklasifikasian Kekurangan Energi Protein (KEP) berdasarkan Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Permenkes RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

Indeks	Kategori	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD

F. Manifestasi Klinis

Gejala klinis pada anak yang mengalami Kekurangan Energi Protein (KEP) yaitu: anak terlihat sangat kurus, mengalami edema atau pembengkakan, indikator penilaian status gizi BB/PB atau BB/TB kurang dari -3 SD, LILA kurang dari 11,5 cm untuk anak usia 6 – 59 bulan, anak memiliki satu atau lebih komplikasi medis seperti anoreksia, pneumonia berat, anemia berat, dehidrasi berat, demam tinggi, dan penurunan kesadaran, disertai defisiensi zat gizi mikro, rambut anak merah dan mudah rontok serta mudah dicabut dan tidak sakit (IDAI, 2009).

Gejala klinis KEP berat/gizi sesuai klasifikasinya:

- a) Kwashiorkor
 - Adanya edema diseluruh tubuh terutama kaki, tangan atau anggota badan lain
 - Wajah membulat dan sembab
 - Pandangan mata sayu
 - Rambut tipis, kemerahan seperti rambut jagung
 - Perubahan status mental: cengeng, rewel
 - Pembesaran hati
 - Otot mengecil
 - Edema simetris pada kedua punggung kaki, dapat sampai seluruh tubuh.
 - Perubahan kulit berupa bercak merah muda yang meluas (dermatosis)
 - Diare
 - Anemia
- b) Marasmus
 - Tampak sangat kurus
 - Wajah seperti orang tua
 - Perubahan mental dan cengeng
 - Lemak subkutan menghilang hingga turgor kulit berkurang, kulit keriput.
 - Otot atrofi sehingga kontur tulang terlihat jelas
 - Kadang-kadang terdapat bradikardi.
 - Tekanan darah rendah, detak jantung dan pernafasan berkurang
- c) Marasmus-kwashiorkor
 - Gambaran klinik merupakan campuran dari beberapa gejala klinik kwashiorkor dan marasmus secara bersamaan (IDAI, 2009).

G. Komplikasi

Kekurangan gizi pada masa balita akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), kekurangan gizi yang fatal dapat mempengaruhi perkembangan otak, menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sikap apatis, gangguan bicara, tingkat *intelligence quotient* (IQ) yang rendah, penurunan

integrasi sensorik, penurunan kepercayaan diri dan kinerja akademik, meningkatnya kecacatan dan kematian.

H. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan laboratorium digunakan untuk mempelajari status nutrisi, termasuk ukuran protein plasma, seperti albumin, transferrin, retinol yang mengikat protein, total kapasitas ikatan zat besi, dan hemoglobin, kadar gula darah, darah tepi lengkap, urin lengkap, faeces lengkap, protein serum (albumin, globulin), test Mantoux, radiologi (dada, AP dan lateral), Elektoradiogram (IDAI, 2009). Pemeriksaan dilakukan guna melihat: keseimbangan cairan, fungsi hati, fungsi ginjal dan *causal disease* atau penyakit penyerta lainnya.

I. Penatalaksanaan

Anak dengan defisiensi gizi tidak selalu dirawat di rumah sakit kecuali yang menderita malnutrisi berat, seperti: kwashiorkor, marasmus, marasmus-kwashiorkor atau malnutrisi dengan komplikasi penyakit lainnya. Kegiatan tatalaksana pada anak dengan KEP, perawat perlu berkolaborasi dengan tenaga profesional lainnya. KEP berat ditata laksana melalui 3 fase (stabilisasi, transisi dan rehabilitasi) dengan 10 langkah tindakan seperti pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Sepuluh langkah tata laksana MEP Berat (IDAI, 2009)

No	FASE	STABILISASI Hari ke 1-2	Hari ke 2-7	TRANSISI Minggu ke-2	REHABILITASI Minggu ke 3-7
1	Hipoglikemia	→			
2	Hipotermia	→			
3	Dehidrasi	→			
4	Elektrolit	→		→	
5	Infeksi	→		→	
6	Mulai Pemberian Makanan (F-75)	→			
7	Pemberian Makanan utk Tumbuh kejar (F-100)			→	→
8	Mikronutrien	→ Tanpa Fe	→	dengan Fe	→
9	Stimulasi	→			→
10	Tindak lanjut				→

Tabel 3. Kebutuhan energi, protein dan cairan sesuai fase-fase tata laksana gizi buruk

	Stabilisasi (F75)	Transisi (F75→F100)	Rehabilitasi (F100)
Energi	80-100 kkal/KgBB/hr	100-150 kkal/ KgBB /hr	150-220/ KgBB /hr
Protein	1-1.5 g/KgBB/hr	2-3 g/ KgBB/hr	4-6 g/ KgBB/hr
Cairan	100-130 ml/kgBB/hr Bila ada edema berat: 100 kkal/ KgBB/hr	bebas sesuai kebutuhan energi	

J. Pengobatan atau Medikemantosa

Pengobatan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit :

1. Rehidrasi secara oral dengan resomal, secara parenteral hanya pada dehidrasi berat atau syok.
2. Atasi/cegah hipoglikemi
3. Atasi gangguan elektrolit
4. Atasi/cegah hipotermi
5. Antibiotika:
 - a. Bila tidak jelas ada infeksi, berikan kotrimoksasol selama 5 hari
 - b. Bila infeksi nyata: ampicilin IV selama 2 hari, dilanjutkan dengan oral sampai 7 hari, ditambah dengan gentamisin IM selama 7 hari
 - c. Atasi penyakit penyerta yang ada sesuai pedoman.
 - d. Vitamin A (dosis sesuai usia, yaitu 1 tahun : 200.000 SI) pada awal perawatan dan hari ke-15 atau sebelum pulang.
 - e. Multivitamin-mineral, khusus asam folat hari pertama 5 mg, selanjutnya 1 mg per hari
 - i. Penatalaksanaan keperawatan. Masalah pasien yang perlu diperhatikan adalah memenuhi kebutuhan gizi, bahaya terjadinya komplikasi, gangguan rasa aman dan nyaman/psikososial dan kurangnya pengetahuan orang tua pasien mengenai makanan (Hockenberry et al., 2017).
 - ii. Penatalaksanaan diet dengan memberikan diet energi, tinggi protein, cukup vitamin dan mineral secara bertahap agar penderita mencapai status gizi optimal (Merryana Adriani, 2016). Ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian diet pada anak Kekurangan Energi Protein (KEP) yaitu pemberian diet, pemantauan dan evaluasi, penyuluhan gizi serta tindak lanjut . Syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan intervensi yaitu dengan:
 - Kebutuhan energi mulai dari 100 – 200 Kal/kg BB per hari
 - Kebutuhan protein mulai dari 1 – 2 gram/kg BB per hari
 - Pemberian suplementasi vitamin dan mineral bila ada defisiensi
 - Jumlah cairan 150 – 200 ml/kgBB per hari, bila ada edema dikurangi
 - Cara pemberian per oral atau lewat pipa nasogastrik
 - Porsi kecil dan frekuensi sering
 - Makanan fase stabilisasi harus hiposmolar, rendah laktosa,

dan rendah serat

- Membedakan jenis makanan berdasarkan berat badan, bila $BB < 7 \text{ kg}$ maka diberikan makanan bayi dan $BB > 7 \text{ kg}$ diberikan makanan anak secara bertahap.
- Terus memberikan ASI jika masih masa menyusui
- Mempertimbangkan hasil anamnesis riwayat gizi
- Pada masa rehabilitasi dapat diberikan suplemen zat gizi mikro dan PMT yang sesuai untuk tumbuh kejar.

Kebutuhan nutrisi yang rekomendasikan dikelompokkan berdasar usia anak (terutama anak berumur kurang dari 5 tahun yaitu :

1. Usia 0-6 Bulan

Bayi 0-6 bulan : nutrisi yang paling tepat diberikan adalah ASI saja tanpa tambahan minuman atau makanan lainnya atau ASI Eksklusif. ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan ibu sejak usia 0 hari-6 bulan tanpa makanan atau minuman lain. Usia enam bulan pertama bayi hanya membutuhkan ASI, karena ASI mengandung seluruh cairan yang dibutuhkan bayi, bahkan dalam cuaca yang panas. Sebaiknya jangan berikan apapun selain ASI (bahkan air putih sekalipun) kepada bayi selama enam bulan pertama. Memberikan air putih dan cairan lain akan membuat bayi kenyang, sehingga jarang menyusui, akhirnya produksi ASI berkurang. Beberapa hari pertama, kebanyakan bayi ingin menyusui 8-12 kali sehari. Ketika pemberian ASI sudah mantap, susui bayi 8 kali atau lebih, agar produksi ASI ibu tetap banyak. Pemberian ASI yang sering dilakukan (dengan pelekatan yang baik) maka produksi ASI semakin banyak. Kecukupan pemberian ASI dapat di lihat dari kenaikan BB, jumlah urine yang keluar dan tanda kepuasan ketika selesai menyusui (Utami, 2021).

2. Usia 7-24 Bulan

Mulai diberikan makanan pendamping ketika anak diatas usia 6 bulan, ASI tetap dilanjutkan. Ketika usia 6-9 bulan kenalkan anak tentang rasa dan secara perlahan jumlah makanannya, berbentuk kental atau dilumatkan dengan makanan pokok seimbang. Usia 9-12 bulan sajikan makanan keluarga yang dicincang/ dicacah. Makanan dengan potongan kecil yang dapat dipegang dan makanan yang diiris-iris. Usia 12-24 bulan sajikan makanan keluarga, kemampuan anak untuk mengunyah dan makan menjadi lebih siap.

3. Usia 24 bulan sampai remaja

Pada usia ini kemampuan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan

nutrisi sudah mulai muncul, sehingga segala peralatan yang berhubungan dengan makan seperti garpu, piring, sendok dan gelas semuanya harus dijelaskan pada anak atau diperkenalkan dan dilatih tentang penggunaannya, sehingga dapat mengikuti aturan yang ada. Pemenuhan nutrisi pada usia ini sebaiknya penyediaan makanan dengan gizi seimbang yaitu keadaan yang menjamin tubuh memperoleh makanan yang cukup mengandung semua gizi dalam jumlah yang dibutuhkan, diantaranya adalah 4 pilar gizi seimbang serta 10 pesan gizi seimbang atau dikenal dengan PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang). Upayakan sajian makanan dengan bervariasi agar tidak bosan (Utami et al., 2021).

K. Pengkajian Keperawatan

1) Riwayat keluhan saat ini:

- Anak perempuan, usia 2,5 tahun dirawat dengan Kwashiorkor, keluhan utama tidak nafsu makan, riwayat keluhan : tidak nafsu makan disertai terjadi perubahan permukaan kulit, Adanya edema di kaki dan tangan.
- Alasan masuk RS: orangtua pasien mengatakan anaknya saat di rumah tidak mau makan kira-kira sejak seminggu yang lalu. Pasien tampak lemah, rewel terjadi perubahan pada permukaan kulit, Keluarga membawa anak ke RS dan dianjurkan untuk dirawat inap.

2) Riwayat nutrisi:

Pemberian ASI sejak lahir sampai dengan usia 12 bulan. Pemberian susu formula tidak pernah diberikan. Pemberian Makanan Tambahan: sejak usia 4 bulan, jenis nasi tim dan sayur. Pola pemberian nutrisi: usia 0-3 bulan diberikan ASI saja, usia 4-12 bulan dilanjutkan dengan ASI dan nasi serta sayur sampai sekarang, usia saat ini anak makan nasi dan sayur saja.

3) Pemeriksaan Fisik

Hasil pemeriksaan didapatkan :

a) Keadaan Umum :

BB sebelum 11,4 kg, BB sesudah 9,4 kg

Pemeriksaan antropometri TB: 80 cm, LK 47 cm, LILA: 10,5cm.

Tanda-tanda vital: S: 36,5, N: 80 x/ menit, RR : 22 x/ mnt

(1) *Head to toe*

(a) Kulit/ integument:

Warna kulit mengalami hiperpigmentasi, kulit bersisik, kering, turgor kulit tidak elastis, tidak ada nyeri tekan.

(b) Kepala dan rambut:

Rambut tipis kemerahan, rambut menyebar tidak merata, tampak kusam dan kering, tidak ada lesi, mudah rontok dan

tipis, teraba tidak ada benjolan.

(c) Kuku:

Tidak terdapat sianosis, kuku bersih dan berwarna merah muda.

(d) Mata/Penglihatan:

Simetris, sklera putih, konjungtiva pucat, tidak teraba benjolan, tidak ada nyeri tekan, penglihatan normal.

(e) Hidung/Penciuman:

Simetris, tidak ada sumbatan, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan, penciuman normal.

(f) Telinga/pendengaran:

Simetris, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan, penciuman normal.

(g) Mulut dan Gigi:

Mukosa bibir kering, ada karies pada gigi, tidak ada nyeri tekan, tidak teraba benjolan, terlihat bersih.

(h) Leher

Tidak terdapat pembesaran JVP, tidak ada lesi, tidak terdapat pembengkakan kelenjar tiroid dan kelenjar limfe.

(i) Dada

Dada bentuk simetris, tidak terdapat lesi, gerakan dada simetris, tidak ada pembengkakan, terdengar sonor kiri dan kanan, terdengar bunyi vesikuler.

(j) Abdomen:

Tidak Ada asites, tidak ada lesi, tidak ada nyeri tekan, ada pembesaran hati, bunyi hypertimpani, bising usus 12x/menit.

(k) Genitalia:

Bersih tidak terpasang kateter

(l) Ekstermitas atas dan bawah:

Terdapat edema ringan pada kaki, ekstermitas atas dan bawah aktif, ROM terbatas karena ekstermitas atas bagian kiri terpasang IVFD dan adanya edema, lemah.

K. Analisa Data

No	Analisa Data	Etiologi	Diagnosa Keperawatan
1.	DS: - Orang tua pasien mengatakan pasien tidak ada nafsu makan. DO: - Pasien nampak lemah - Pasien nampak kurus - Edema pada ekstermitas kaki dan tangan. - Rambut tipis kemerahan, rambut menyebar tidak merata, tampak kusam dan kering, mudah rontok - BB turun > 10% dari BB ideal. - BB: 9,4 kg (sebelumnya 11,4kg), TB: 80cm, LILA: 10,5 cm - Tanda vital: Tekanan darah 100/70, suhu 36,5°C, nadi 80x/menit, pernafasan 22x/menit.	Kurangnya asupan makanan	Defisit Nutrisi (D 0019)
2.	DS: - Orangtua pasien mengatakan pasien mengalami perubahan permukaan kulit. DO: - Turgor kulit tidak elastis - Warna kulit mengalami hiperpigmentasi - Kulit bersisik - Kulit kering	Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan)	Gangguan integritas kulit/jaringan (D 0129)
3.	DS :- DO : - Pertumbuhan fisik terganggu - Tidak nafsu makan - Lemah - S : 36,5 - N : 80 x/ menit - RR : 22 x/ mnt - Terdapat edema ringan pada kaki, ekstermitas atas dan bawah aktif, ROM terbatas	Efek ketidakmampuan fisik	Gangguan tumbuh kembang (D 0106)

L. Diagnosa Keperawatan

No	Diagnosa Keperawatan
1.	Defisit nutrisi b.d Kurangnya asupan makanan (D 0019)
2.	Gangguan integritas kulit/jaringan b.d perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) (D 0129)
3.	Gangguan tumbuh kembang b.d Efek ketidakmampuan fisik (D 0106)

M. Intervensi Keperawatan

NO	SDKI	SLKI	SIKI
1.	Defisit nutrisi Tanda Mayor: Subyektif: - Objektif: 1. BB menurun minimal 10% dibawah rentang normal. Tanda Minor: Subjektif: 1. Cepat kenyang setelah makan. 2. Kram atau nyeri abdomen. 3. Nafsu makan menurun. Objektif: 1. Bising usus hiperaktif 2. Otot pengunyah lemah 3. Otot menelan lemah 4. Membrane mukosa pucat. 5. Sariawan 6. Albumin turun. 7. Rambut rontok berlebihan. 8. Diare.	Setelah dilakukan tindakan Keperawatan 1x24 jam maka status nutrisi membaik. Kriteria hasil: - Porsi makan - Berat badan - IMT - Frekuensi makan	Manajemen nutrisi Observasi: 1. Identifikasi status nutrisi 2. Monitor BB Terapeutik 3. Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai 4. Berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein Edukasi 5. Anjurkan posisi duduk, jika mampu. Kolaborasi 6. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrient
2.	Gangguan integritas kulit/jaringan Tanda mayor: Subyektif: Objektif: 1. Kerusakan kulit dan atau lapisan kulit Tanda minor: Subjektif:- Objektif: 1. Nyeri 2. Perdarahan 3. Kemerahan 4. Hematom	Setelah dilakukan tindakan Keperawatan 1x24 jam maka integritas kulit dan jaringan meningkat. Kriteria hasil: - Kerusakan jaringan - Kerusakan lapisan kulit	Perawatan integritas kulit. Observasi 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit Terapeutik 2. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Edukasi 3. Anjurkan gunakan pelembab 4. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 5. Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. Kolaborasi
3.	Gangguan tumbuh kembang	Setelah dilakukan tindakan Keperawatan	Promosi berat badan

NO	SDKI	SLKI	SIKI
	Tanda mayor Subjektif:- Objektif: 1. Tidak mampu melakukan ketrampilan atau perilaku khas sesuai usia (fisik, Bahasa, motorik dan psikososial) 2. Pertumbuhan fisik terganggu Tanda Minor Subjektif:- Objektif: 1. Tidak mampu melakukan perawatan diri sesuai usia 2. Afek datar 3. Respon sosial lambat 4. Kontak mata terbatas 5. Nafsu makan menurun 6. Lesu 7. Mudah marah 8. Regresi 9. Pola tidur terganggu	1x24 jam maka status pertumbuhan dan perkembangan membaik. Kriteria hasil: - Status perkembangan - Berat badan - Kinerja pengasuhan - Perawatan diri - Perlekatan - Status pertumbuhan	Observasi 1. Identifikasi kemungkinan penyebab BB kurang. 2. Monitor adanya mual, muntah 3. Monitor jumlah kalori yang dikonsumsi sehari-hari 4. Monitor BB 5. Monitor albumin, limfosit, dan elektrolit serum Terapeutik 6. Berikan perawatan mulut sebelum pemberian makan jika perlu 7. Sediakan makanan yang tepat sesuai kondisi pasien (misal makanan dengan tekstur halus, makanan yang diblender, makanan cair yang diberikan dengan NGT atau gastrostomi, total parenteral sesuai indikasi) 8. Hidangkan makanan secara menarik 9. Berikan suplemen jika diperlukan. 10. Berikan pujian pada pasien Edukasi 11. Jelaskan jenis makanan yang bergizi namun tetap terjangkau. 12. Jelaskan peningkatan asupan kalori yang dibutuhkan.

N. Implementasi Keperawatan

Tgl	Waktu	Diagnosa Keperawatan	Pelaksanaan Keperawatan	Nama jelas
		Defisit Nutrisi	- identifikasi status nutrisi - identifikasi makanan yang disukai - monitor asupan makanan - monitor berat badan - Identifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak - Fasilitasi hubungan anak dengan teman sebaya - Dukung anak berinteraksi dengan anak lain - Demonstrasikan kegiatan yang meningkatkan perkembangan anak - Berikan konseling tentang makanan gizi seimbang, isi piringku	
		Gangguan integritas kulit/ jaringan	- Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit. - Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. - Anjurkan gunakan pelembab - Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi - Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur. - Kolaborasi	
		Gangguan tumbuh kembang	- Mengidentifikasi pencapaian tugas perkembangan anak - Mengidentifikasi isyarat perilaku dan fisiologis yang ditujukan anak seperti lapar dan tidak nyaman - memperperthahankan lingkungan yang mendukung perkembangan anak, suhu ruangan - memfasilitasi anak melatih keterampilan pemenuhan kebutuhan secara mandiri, berlatih untuk berjalan - menjelaskan/ mengedukasi kepada orang tua/pengasuh tentang milestone perkembangan anak dan perilaku anak - kolaborasi rujuk untuk konseling dokter spesialis anak.	

O. Evaluasi Keperawatan

Tanggal	Evaluasi Keperawatan	Nama Jelas
	Defisit nutrisi b.d ketidakmampuan menelan S : - pasien tidak mengeluh mual dan muntah - ibu pasien mengatakan pasien cepat kenyang setelah makan O : - pasien hanya makan 3 sendok makan A : - masalah deficit nutrisi teratasi, status nutrisi membaik dengan nafsu makan membaik - frekuensi makan mulai membaik P : - hentikan intervensi dengan tetap memantau status nutrisi pasien	
	Gangguan integritas kulit/ jaringan b.d perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan) S : - ibu pasien mengatakan kulit pasien lembab - pasien tidak mengalami kerusakan kulit O : - pasien menghabiskan porsi makan - BB meningkat - Kulit utuh A : - masalah gangguan integritas kulit teratasi - status nutrisi baik - BB ideal pasien tercapai P : - hentikan intervensi dengan tetap memantau status nutrisi pasien dan keutuhan kulit	
	Gangguan tumbuh kembang b.d efek ketidakmampuan fisik S : O : - pasien memiliki pertumbuhan fisik yang terganggu - BB dan TB mulai meningkat A : - nafsu makan pasien teratasi - pertumbuhan fisik pasien membaik P : - hentikan intervensi dan tetap pantau tumbuh kembang pasien	

DAFTAR PUSTAKA

- Hockenberry, M. ., Wilson, D., & Rodgers, C. (2017). *Wong's Essentials of Pediatrics Nursing*. Elsevier.
- IDAI. (2009). *PEDOMAN PELAYANAN MEDIS IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA* (I. D. A. I. IDAI(ed.)). IDAI.
- Kemenkes RI. (2014). *Pedoman Gizi Seimbang*. 1–96.
- Kemenkes RI. (2020). *STANDAR ANTROPOMETRI ANAK*. 3, 1–78.
- Kemenkes RI. (2021). buku saku hasil studi status gizi indonesia (SSGI) tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota tahun 2021. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Kusumawardani, L. H., Khoiriyah, A., Trenggono, A. H., Saputra, R. B., Annisa, S. N., Muniroh, S. W., ... & Purnomo, D. (2020). Peningkatan Pengetahuan Gizi Seimbang pada Ibu Balita Melalui Edukasi dan Simulasi Pembuatan Makanan Bergizi di Desa Kebumen, Baturraden. *Journal of Bionursing*, 2(1), 9–14.
- Merryana Adriani, S. K. M. (2016). *Pengantar gizi masyarakat*. Prenada Media.
- Nurhayati, S., & Nugroho, P. S. (2021). Pengaruh Kebiasaan Sarapan dan Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Gizi Kurang Pada Remaja. *Borneo Student Research (BSR)*, 2(2), 1223–1228.
- Nurwijayanti. (2019). Keterkaitan Kekurangan Energi Protein (KEP) dengan Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita Usia (1-5 Tahun). *Jurnal Care*, 4(3), 30–36.
- Putri, N. E., Andarini, M. Y., & Achmad, S. (2021). Gambaran Status Gizi pada Balita di Puskesmas Karang Harja Bekasi. *Jurnal Riset Kedokteran*, 1(1), 14–1.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia (PPNI)
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia (PPNI)
- Tim Pokja SLKI PPNI. (2018). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Persatuan Perawat Indonesia (PPNI)
- Utami, T. A. (2021). Kebutuhan nutrisi dan cairan pada anak. *STIK Sint Carolus*, 40.
- Utami, T. A., Redjeki, S., & B.Tokan, Y. (2021). Menstimulus Tumbuh Kembang Balita Dengan Gizi Seimbang Pada Masa Pandemi Covid-19. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 4/6, 1498–1504
<http://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/kreativitas/article/view/4571>
- WHO, UNICEF, G. B. D. (2020). *Tingkat dan Tren Gizi Buruk Pada Anak*. 1–32.

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN OBESITAS

Citra Setyo Dwi Andhini, S.Kep.,Ners.,M.Kep.



ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN OBESITAS

Citra Setyo Dwi Andhini, S.Kep.,Ners.,M.Kep.

A. Definisi

Obesitas adalah akumulasi lemak berlebih atau abnormal yang tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin, serta melampaui kondisi berat badan berlebih (overweight) (Tim Pokja SDKI PPNI, 2017). Overweight atau gizi lebih dan obesitas diartikan sebagai penumpukan abnormal atau kelebihan lemak dari pada yang diperlukan tubuh, dinilai berdasarkan berat badan/BB (Kg) per panjang badan/PB atau tinggi badan/TB (m^2) untuk anak usia 0-60 bulan (<5 tahun) dan IMT (Indeks Massa Tubuh) per usia untuk anak 5-18 tahun. Penentuan overweight dan obesitas pada anak merujuk pada tabel antropometri dan grafik pertumbuhan anak berdasarkan standar WHO. Untuk anak usia < 5 tahun (PB atau TB per BB), dikatakan anak overweight jika BB/PB atau BB/TB: Z skor >+2 sampai dengan +3 SD standar deviasi (SD) dan obesitas jika BB/PB atau BB/TB : Z skor >+3 SD. Untuk anak usia 5-18 tahun (IMT/Usia), dikatakan overweight jika diperoleh Z skor >+2 sampai dengan +3 SD, dan obesitas jika Z skor >+3SD (Kementrian Kesehatan RI, 2018). Anak dengan obesitas beresiko untuk menderita penyakit jantung, resistensi insulin, penyakit diabetes mellitus tipe 2, masalah dalam pernapasan (apnea), masalah sendi dan ketidaknyamanan musculoskeletal, masalah psikologis seperti kecemasan dipresi, harga diri rendah dan bullying (Rahayu, dkk, 2022).

B. Etiologi

Faktor risiko obesitas dipengaruhi oleh banyak faktor, sebagian besar faktor risiko obesitas yaitu jenis kelamin, faktor genetic dan faktor lingkungan antara lain aktivitas fisik, asupan makan, social ekonomi.

1. Keturunan

Faktor keturunan juga dapat mempengaruhi pembentukan lemak tubuh. Seseorang mempunyai faktor keturunan yang cenderung membangun lemak tubuh lebih banyak dibandingkan orang lain. Bawaan sifat metabolisme ini menunjukkan adanya gen bawaan pada kode untuk enzim lipoprotein lipase yang lebih efektif. Enzim ini memiliki suatu peranan penting dalam proses mempercepat penambahan berat badan karena enzim ini bertugas mengontrol kecepatan trigiserida dalam darah yang dipecah-pecah menjadi asam lemak dan disalurkan ke sel-sel tubuh untuk di simpan sehingga lama kelamaan menyebabkan penambahan berat badan. Parental fatness merupakan faktor keturunan yang berperan besar. Jika kedua orang tua obesitas, 80% anaknya akan menderita obesitas, namun jika salah satu orang tuanya obesitas maka

kejadian obesitas 40% dan bila kedua orang tuanya tidak obesitas maka prevalensinya menjadi 14% (Palupi, 2014). Sehingga faktor keturunan orang tua menderita obesitas mempengaruhi kejadian obesitas pada anak.

2. Konsumsi makan

Konsumsi makan adalah semua jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari (Palupi, 2014). Secara biologis makanan berfungsi memenuhi kebutuhan energi, zat gizi dan komponen kimiawi yang dibutuhkan tubuh yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Metabolisme zat gizi yang terjadi di dalam tubuh berperan menghasilkan energi, membangun sel, dan memelihara keseimbangan elektrolit dan sistem daya tahan. Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang optimal apabila tubuh memperoleh cukup zat – zat gizi yang dapat digunakan secara efisien. Obesitas muncul pada usia remaja cenderung berlanjut ke dewasa dan lansia.

3. Sosial ekonomi

Faktor ekonomi yang cukup dominan dalam konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga dan harga pangan. Meningkatnya pendapatan akan meningkatkan peluang untuk membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik, sebaliknya penurunan pendapatan keluarga akan menyebabkan menurunnya daya beli pangan baik secara kualitas maupun kuantitas. Meningkatnya taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat, pengaruh promosi iklan, serta kemudahan informasi, dapat menyebabkan perubahan gaya hidup dan timbulnya kebutuhan psikogenik baru dikalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas. Tingginya pendapatan yang tidak diimbangi dengan pengetahuan gizi yang cukup, akan menyebabkan seseorang menjadi sangat konsumtif dalam pola makannya sehari – hari, didasarkan pada pertimbangan selera dibandingkan dari aspek gizi.

4. Jenis kelamin

Kebutuhan zat gizi antara laki-laki dan perempuan berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena jaringan penyusun tubuh dan aktivitasnya. Jaringan lemak pada perempuan cenderung lebih tinggi dari pada laki-laki. Sedangkan laki-laki cenderung lebih banyak memiliki jaringan otot. Hal ini menyebabkan lean body mass laki-laki menjadi lebih tinggi dari pada perempuan Menurut WHO 2000, perempuan lebih cenderung mengalami peningkatan penyimpanan lemak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan perempuan terhadap asupan makan sumber karbohidrat yang lebih banyak sebelum masa pubertas, sementara kecenderungan laki-laki mengkonsumsi makanan kaya protein. Kebutuhan zat gizi anak laki – laki berbeda dengan anak perempuan dan biasanya lebih tinggi karena anak laki-laki memiliki aktivitas fisik yang lebih tinggi.

Aktivitas fisik

Aktivitas fisik adalah pergerakan tubuh dihasilkan oleh otot rangka yang mengeluarkan energi. Penggunaan energi bervariasi tergantung tingkat aktivitas fisik dan pekerjaan yang berbeda. Aktivitas fisik berguna untuk melancarkan peredaran darah dan membakar kalori. Aktivitas fisik akan membakar energi yang masuk, sehingga jika asupan kalori berlebih serta kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan akan menyebabkan tubuh mengalami kegemukan. Aktivitas fisik dapat menurunkan risiko hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes.

C. Patofisiologi

Obesitas dapat ditandai dengan penumpukan lemak yang berlebih atau terjadi dalam kompartemen jaringan adipose yang berbeda. Proses adipogenesis terjadi pada dua periode sensitive, yaitu setelah kelahiran dan pubertas. Gangguan metabolisme ini terjadi ketika asupan energi dan energi yang dikeluarkan tidak seimbang. Pusat integrasi nafsu makan dan regulasi berat badan terjadi di hipotalamus mediobasal (Hastuti, 2019). Energi yang dikeluarkan rendah sebagai akibat dari rendahnya metabolisme tubuh, aktivitas fisik, dan efek termogenesis makanan. Efek termogenesis makanan ditentukan oleh konsumsi makanan. Lemak memberikan efek termogenesis lebih rendah (3% dari total energi yang dihasilkan lemak) dibandingkan dengan karbohidrat (6-7% dari total energi yang dihasilkan karbohidrat) dan protein (25% dari total energi yang dihasilkan protein) (Effendi, 2021). Sebagian besar gangguan homeostatis energi ini disebabkan oleh faktor idiopatik (obesitas primer atau nutrisi), sedangkan faktor endogen (obesitas sekunder atau non-nutrisi) yang disebabkan oleh kelainan hormonal, sindrom atau defek genetik) hanya mencakup kurang dari 10% kasus (Effendi, 2021).

Pusat integrasi nafsu makan dan regulasi berat badan terjadi di hipotalamus mediobasal (Hastuti, 2019). Pengaturan tersebut melalui tiga proses fisiologis, yaitu pengendalian rasa lapar dan kenyang, memengaruhi laju pengeluaran energi, serta regulasi sekresi hormone. Proses dalam pengaturan penyimpanan energi ini terjadi melalui sinyal-sinyal eferen (yang berpusat di hipotalamus) setelah mendapatkan sinyal aferen dari perifer (jaringan adipose, usus dan jaringan otot) (Effendi, 2021). Sinyal-sinyal tersebut bersifat anabolic (meningkatkan rasa lapar dan menurunkan pengeluaran energi) dan dapat pula bersifat katabolic (anoreksia, meningkatkan pengeluaran energi), dan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sinyal pendek dan sinyal panjang. Sinyal pendek memengaruhi porsi makan dan waktu makan, serta berhubungan dengan faktor distensi lambung dan peptide gastrointestinal, yang diperankan oleh kolesistokinin (CCK) sebagai stimulator dalam peningkatan rasa lapar. Sinyal panjang diperankan oleh fat-derived hormone leptin dan insulin yang mengatur penyimpanan dan keseimbangan energi.

Jaringan adipose akan meningkat disertai dengan peningkatan kadar leptin dalam peredaran darah apabila asupan energy melebihi jumlah yang dibutuhkan anak. Selanjutnya, leptin merangsang anorexigenic center di hipotalamus agar menurunkan produksi neuro peptide Y (NPY), sehingga terjadi penurunan nafsu makan. Sebaliknya, bila kebutuhan energy lebih besar daripada asupan energy, jaringan adipose berkurang dan terjadi rangsangan pada orexigenic center di hipotalamus yang menyebabkan peningkatan nafsu makan. Pada sebagian penderita obesitas terjadi resistensi leptin, sehingga tingginya kadar leptin tidak menyebabkan penurunan nafsu makan.

D. Manifestasi Klinis

- 1) IMT $>27 \text{ kg/m}^2$ (pada dewasa) atau lebih dari presentil ke 95 untuk usia dan jenis kelamin(pada anak)
- 2) Tebal lipatan kulit trisep $>25\text{mm}$. (Tim Pokja SDKI PPNI, 2017)

E. Komplikasi

Beberapa dampak yang terjadi dalam jangka panjang menurut (Kemenkes, 2011) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sindrom resisten insulin
Bagi anak yang mengalami kegemukan sekitar perut, terutama yang bertipe buah apel, umumnya mengalami penurunan jumlah insulin dalam darah. Akibatnya hal tersebut memicu anak terserang Diabetes Millitus tipe 2. Penderita DM tipe 1 selain memiliki kadar glukosa yang tinggi, juga memiliki kadar insulin yang tinggi atau normal. Keadaan inilah yang disebut sindrom resistensi insulin atau sindrom X.
2. Tekanan Darah Tinggi
Obesitas adalah salah satu penyebab utama yang mempengaruhi tekanan darah. Sekitar 20-30% anak yang kegemukan mengalami Tekanan darah tinggi.
3. Penyakit Jantung Koroner
Penyakit yang terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Risiko terkena penyakit jantung koroner semakin meningkat seiring dnegan perubahan terjadinya penambahan berat badan yang berlebihan. Penyakit jantung koroner tidak selalu akibat kegemukan, tetapi diperburuk oleh faktor risiko lain yang terjadi pada masa kanak- kanak seperti Hipertensi, Kolesterol tinggi dan Diabetes.
4. Gangguan pernafasan seperti Asma, Nafas pendek, Menggorok saat tidur dan tidur Apnue (terhentinya pernafasan untuk sementara waktu ketika

sedang tidur). Hal ini disebabkan karena penimbunan lemak yang berlebihan di bawah diafragma dalam dinding dada yang menekan paru-paru

5. Gangguan tulang persendian

Beban tubuh anak yang terlalu berat mengakibatkan gangguan ortopedi dan gangguan lain yang sering dirasakan adalah nyeri punggung bawah dan nyeri akibat radang sendi.

F. Penatalaksanaan

1. Pola makan

Pola makan mencakup jumlah, jenis, jadwal makan dan pengolahan bahan makanan. Bila menggunakan piring makan model T maka jumlah sayur 2 kali lipat jumlah bahan makanan sumber karbohidrat (nasi, mie, roti, pasta, singkong, dan lain-lain) dan jumlah bahan makanan sumber protein setara dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat. Sayur dan atau buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Atur pola makan dengan menggunakan piring makan model T sebagai berikut:

- Konsumsi sayur 2 kali lipat dari jumlah bahan makanan sumber karbohidrat (sayur=2 kali jumlah karbohidrat) Asupan sayur dianjurkan sebesar 5-6 porsi sedangkan buah minimal 3 porsi per hari, sayur dan buah berfungsi memelihara mikroflora, kanker kolon. Bahkan, asupan secara benar dan sesuai maka buah dan sayur akan mencegah penyakit berat, Appendicitis, Diabetes, Penyakit Jantung Koroner dan Obesitas. Serat merupakan komponen penyusun diet manusia yang sangat penting, dengan adanya serat, maka penyerapan karbohidrat, lemak dan protein menjadi berkurang. Jika hal ini dilakukan secara teratur dan berkesinambungan, maka kegemukan dapat dihindari. Serat mampu memberikan perasaan kenyang dalam waktu yang cukup lama. Sumber serat yang baik adalah sayuran, buah-buahan, sereal dan kacang-kacangan. Sayuran yang banyak mengandung serat adalah bayam, kangkung, buncis, daun beluntas, daun singkong, kacang panjang, daun katuk, daun kelor, sawi, kecipir, kol dan lain-lain. Buah yang banyak mengandung tinggi serat adalah alpukat, belimbing, kemang, mangga, nanas srikaya, cempedak, nangka dan sebagainya. Sereal yang kaya serat adalah beras, jagung, jait dan jewawut.
- Konsumsi bahan makanan sumber protein sama dengan jumlah bahan makanan sumber karbohidrat ($P = KH$)
Konsumsi makanan sumber protein sejumlah bahan makanan bersumber karbohidrat. Tubuh mencerna protein lebih lambat dari lemak atau karbohidrat, sehingga akan terasa kenyang lebih lama. Protein juga dapat

meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam proses berasal dari bahan makanan seperti daging unggas, ikan, telur, produk susu, kedelai, kacang-kacangan dan bijibijian. Dianjurkan untuk memilih bahan makanan sumber protein yang mengandung lemak rendah dan lemak sedang. Protein hewani yang rendah lemak diantaranya daging ayam tanpa kulit, putih telur ayam, ikan lele, ikan mas, udang segar dan lain-lain. Sedangkan protein hewani lemak sedang seperti daging sapi, daging kambing, hati ayam, hati sapi, telur ayam dan lain-lain.

- Konsumsi sayur atau buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat ditambah protein ($SB = KH + P$)

Konsumsi buah dan sayur minimal setara dengan jumlah protein dan karbohidrat yang dikonsumsi. Sayuran kaya akan air dan mengonsumsi sayuran dalam keadaan segar mampu membantu mengisi kebutuhan tubuh akan asupan cairan harian yang sering kali kurang dikonsumsi. Sebaiknya sayuran dikonsumsi dalam keadaan segar karena sayuran yang telah melewati proses pemanasan yang akan merusak cadangan air, enzim, nutrisi dan mineral yang terkandung didalamnya. Pada suhu 40 derajat sewaktu pemanasan enzim akan rusak.

- Minyak sebagai bahan makanan sumber lemak dapat digunakan untuk mengolah bahan makanan, jumlah yang dianjurkan adalah 3-4 porsi atau setara dengan 3-4 sendok teh. Minyak dapat juga digantikan oleh margarin, mentega atau santan. Dianjurkan untuk memilih jenis lemak tak jenuh ganda maupun tunggal seperti minyak zaitun, kacang-kacangan, minyak jagung, minyak biji matahari dan lain-lain. Namun dalam pengolahannya tidak boleh dipanaskan namun ditambahkan ketika makanan telah matang dan siap disajikan (Kemenkes, 2017)

2. Pola Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik dewasa dapat dimulai dengan meningkatkan aktivitas fisik setidaknya selama 30 menit intensitas sedang atau berat sekitar 5 hari atau lebih dalam satu minggu. Aktivitas dalam satu sesi atau beberapa sesi yang berlangsung 10 menit atau lebih. Pasien obesitas yang sudah mengalami penurunan berat badan perlu melakukan aktivitas fisik 60-90 menit sehari untuk mencegah penambahan berat

3. Medikamentaosa dapat ditambahkan pada pasien obesitas dengan $IMT > 30 \text{ kg/m}^2$ atau $IMT > 27 \text{ kg/m}^2$ yang disertai dengan penyakit yang berhubungan dengan obesitas. Obat yang telah Disetujui Food And Drug Administration (FDA) diantaranya Orlistat, Phentermine, Lorcaserin, Liraglutide, Dietilpropion, Phentermine/Topiramate, Naltrexone/Bupropion, Phendimetrazine. (Saridewi.2021).

4. Pembedahan merupakan salah satu pilihan terapi untuk menurunkan berat badan. Indikasi untuk tindakan pembedahan bariatrik adalah indeks massa tubuh (IMT) > 40 atau IMT > 35 yang disertai komorbiditas terkait berat badan, riwayat manajemen berat badan secara medis sebelumnya, tidak ada kontraindikasi psikologis, dan harapan hidup lebih dari 5 tahun. Khusus pada anak dan remaja juga diperhatikan tingkat maturitas tulang (≥ 13 tahun pada wanita dan ≥ 15 tahun pada pria). Di antara tindakan pembedahan yang sering dilakukan pada obesitas antara lain laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB), Rouxen-Y gastric bypass (RYGB) dan sleeve gastrectomy (SG). Follow-up pasca bedah setidaknya dilakukan minimal selama 2 tahun untuk memantau asupan nutrisi (termasuk protein dan vitamin) dan defisiensi mineral, komorbiditas, pengobatan, aktivitas fisik, dukungan psikologis, informasi tentang kelompok profesional atau dukungan sebaya. (Saridewi. 2021)

G. Pengkajian

1. Pengukuran obesitas

Menurut Kemenkes 2011, Pengukuran status Gizi dapat dilakukan dengan metode antropometri. Metode ini menggunakan pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan dan tebal lapisan kulit. Pengukuran tersebut bervariasi menurut umur dan kebutuhan gizi. Antropometri dapat memberikan informasi tentang riwayat gizi masa lampau. Tingkat obesitas dapat dihitung menggunakan menurut standar antropometri.

Tabel 1. Klasifikasi Status Gizi Berdasarkan Permenkes RI Nomor 2 tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak

Indeks	Kategori	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD

2. Riwayat Keperawatan dan diet

- a) Anggara makan, makanan kesukaan, waktu makan
- b) Apakah ada diet yang dilakukan secara khusus
- c) Apakah ada penurunan dan peningkatan berat badan dan berapa lama periode waktunya
- d) Apakah ada status fisik pasien yang dapat meningkatkan diet seperti luka
- e) Apakah ada toleransi makan atau minum tertentu

Faktor yang memengaruhi diet

- a) Status kesehatan
- b) Kultura dan kepercayaan
- c) Status sosial ekonomi
- d) Faktor psikologi
- e) Informasi yang salah tentang makanan dan cara diet

3. Keluhan Utama : berat badan berlebih, mudah lelah

4. Pemeriksaan fisik

- a) Keadaan fisik : Gemuk
- b) Berat badan : obesitas, kegemukan
- c) Otot : Flaksia atau lemah, Tonus kurang, Tenderness, tidak mampu bekerja
- d) Fungsi Gastrointrstinal : Anoreksia, Konstipasi, Diare, Flatulensi, pembesara liver atau limpa.
- e) Kardiovaskuler :Denyut nadi lebih dari 100 kali/menit, irama abnormal, tekanan darah rendah atau tinggi.
- f) Rambut: kusam, kering,pudar,kemerahan,tipis,pecah atau patahpatah
- g) Kulit : kering, pucat,iritasi, ptekie, lemak disubkutan
- h) Bibir: kering, pecah-pecah, bengkak, lesi, stomatitis, membrane mukosa pucat.
- i) Gusi : pendarahan, peradangan.
- j) Lidah : edema, hiperemis
- k) Gigi : karies, nyeri, kotor
- l) Mata: konjungtiva pucat,kering,eksoftalmus, tanda-tanda infeksi
- m) Kuku: mudah patah
- n) Pengukuran antropometri: Berat badan ideal $(TB-100) \times 10\%$
- o) Lingkar pergelangan tangan Lingkar lengan atas (MAC): (nilai normal):
Wanita : 28,5cm dan Pria: 28,3cm
- p) Lipatan kulit pada otot trisep (TSF) (nilai normal): Wanita:16,5-18 cm dan
Pria: 12,5-16,5 cm

5. Laboratorium

- a) Albumin (nilai normal 4-5,5 mg/100ml)
- b) Transferin (nilai normal: 170-25 mg/100ml)
- c) Hb (nilai normal: 12mg%)
- d) BUN (nilai normal :10-20 mg/100ml)
- e) Ekskresi kreatinin untuk 24 jam (nilai normal : laki-laki 0,6-1,3 mg/100ml, wanita 0,5-1,0 mg/100ml) (Tarwoto & Wartonah, 2015:77-78)

H. Diagnosis

1. Diagnosa keperawatan : Berat Badan Lebih

Defisini : akumulasi lemak berlebih atau abnormal yang tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin

Penyebab :

1. kurang aktivitas fisik harian
2. kelebihan konsumsi gula
3. gangguan kebiasaan makan
4. gangguan persepsi makan
5. kelebihan konsumsi alkohol
6. penggunaan energi kurang dari asupan
7. sering mengemil
8. sering memakan makanan berminyak/berlemak
9. faktor keturunan (mis. Distribusi jaringan adiposa, pengeluaran energi aktivitas lipase lipoprotein, sintesis lipid, lipolisis)
10. penggunaan makanan formula atau makanan campuran (pada bayi)
11. asupan kalsium rendah (pada anak-anak)
12. berat badan bertambah cepat (selama masa anak-anak, selama masa bayi, termasuk minggu pertama, 4 bulan pertama, dan tahun pertama)
13. makanan padat sebagai sumber makanan utama pada usia <5bulan

Gejala dan tanda mayor :

Subyektif : (tidak tersedia)

Objektif :

- IMT 25-27 kg/m² (pada dewasa) atau berat dan panjang badan lebih dari persentil 95 (pada anak <2tahun) atau IMT pada persentil ke 85-95 (pada anak 2-18 tahun)

Gejala dan tanda minor

Subyektif: (tidak tersedia)

Obyektif

- Tebal lipatan kulit trisep >25 mm

Kondisi klinis terkait :

- Gangguan genetic
- Faktor keturunan
- Hipotiroid
- Diabetes
- Diabetes mellitus maternal

2. **Obesitas**

Definisi : akumulasi lemak berlebih atau abnormal yang tidak sesuai dengan usia dan jenis kelamin, serta melampaui kondisi berat badan lebih (overweight).

Penyebab :

1. Kurang aktivitas fisik harian
2. kelebihan konsumsi gula
3. gangguan kebiasaan makan
4. gangguan persepsi makan
5. kelebihan konsumsi alcohol
6. penggunaan energy kurang dari asupan
7. sering mengemil
8. sering memakan makanan berminyak/berlemak
9. Faktor keturunan (mis. Distribusi jaringan adipose, pengeluaran energi aktivitas lipase lipoprotein, sintesis lipid, lipolisis)
10. Penggunaan makanan formula atau makanan campuran pada bayi
11. Asupan kalsium rendah pada anak-anak
12. Berat badan bertambah cepat (selama masa anak-anak, selama masa bayi, termasuk minggu pertama, 4 bulan pertama, dan tahun pertama)
13. Makanan padat sebagai sumber makanan utama pada usia <5bulan.

Gejala dan Tanda

- Gejala dan tanda mayor
Objektif : $IMT > 27 \text{ Kg/m}^2$ (pada dewasa) atau lebih presentil ke 95 untuk usia dan jenis kelamin (pada anak).
Subjektif : -
- Gejala dan tanda minor
Objektif : tebal lipatan kulit trisep $> 25\text{mm}$.
Subjektif : -

Kondisi klinis terkait :

- Gangguan Genetic
- Faktor Keturunan
- Hipotiroid
- Diabetes Mellitus Internal.

3. **Diagnosa keperawatan : Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah**

Definisi : Risiko terhadap variasi kadar glukosa darah dari rentang normal

Faktor risiko :

1. Kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes

2. Ketidaktepatan pemantauan glukosa darah
3. Kurang patuh pada rencana manajemen diabetes
4. Manajemen medikasi tidak terkontrol
5. Kehamilan
6. Periode pertumbuhan cepat
7. Stres berlebihan
8. Penambahan berat badan
9. Kurang dapat menerima diagnosis

Kondisi klinis terkait

1. Diabetes melitus
2. Ketoasidosis diabetik
3. Hipoglikemia
4. Diabetes gestasional
5. Penggunaan kortikosteroid
6. Nutrisi parenteral total (TPN)

I. Intervensi

Intervensi keperawatan merupakan tindakan yang dilakukan perawat sesuai dengan kemampuan atau skill yang dimiliki dan penilaian klinis guna meningkatkan, mencegah dan memulihkan kesehatan klien, keluarga dan komunitas (PPNI, 2018). Intervensi disusun berdasarkan diagnose keperawatan yang diambil. Pada materi ini, intervensi yang diambil merupakan intervensi utama sesuai dengan diagnosa keperawatan, yang bersumber pada buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Adapun intervensi yang diberikan meliputi :

1. manajemen nutrisi
2. manajemen berat badan
3. promosi latihan fisik
4. promosi berat badan
5. pengontrolan infeksi
6. edukasi berat badan efektif
7. promosi citra tubuh
8. promosi coping

J. Diagnosa keperawatan : Berat Badan Lebih

Luaran						Intervensi
- Luaran utama : berat badan - Luaran tambahan : perilaku menurunkan berat badan, Status nutrisi, Tingkatansietas, Tingkat kepatuhan, Tingkat pengetahuan Berat Badan : - Definisi : akumulasi bobot tubuh sesuai dengan usia dan jenis kelamin - Ekspektasi : membaik						Intervensi utama : - konseling nutrisi - manajemen berat badan - promosi latihan fisik Intervensi Pendukung : - edukasi diet - manajemen cairan - manajemen hiperglikemia - manajemen hipoglikemia - manajemen nutrisi - manajemen perilaku - modifikasi perilaku - pemantauan nutrisi - promosi coping - reduksi ansietas
	Membu-ruk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup membaik	Membaik	
Berat badan	1	2	3	4	5	
Tebel lipatan kulit	1	2	3	4	5	
Indeks masa tubuh	1	2	3	4	5	
						Konseling Nutrisi: Definisi : memberikan bimbingan dalam melakukan modifikasi asupan nutrisi Tindakan Observasi : - identifikasi kebiasaan makan dan perilaku makan yang akan diubah - identifikasi kemajuan modifikasi diet secara regular - monitor intake dan output cairan, nilai hemoglobin, tekanan darah, kenaikan berat badan, dan kebiasaan membeli makanan Terapeutik : - bina hubungan terapeutik - sepakati lama waktu pemberian konseling - tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang realistis - gunakan standar nutrisi sesuai program diet dalam mengevaluasi kecukupan asupan makanan

	- pertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan gizi (mis. Usia, tahap pertumbuhan dan perkembangan, penyakit) Edukasi : - informasikan perlunya modifikasi diet (mis. Perurunan atau penambahan berat badan, pembatasan natrium atau cairan, pengurangan kolesterol) - jelaskan program gizi dan persepsi pasien terhadap diet yang diprogramkan Kolaborasi : - rujuk pada ahli gizi, jika perlu
--	---

K. Diagnosa keperawatan : Obesitas

Luaran						Intervensi
- Luaran utama : berat badan - Luaran tambahan : Citra Tubuh, perilaku menurunkan berat badan, status nutrisi, tingkat kepatuhan, tingkat pengetahuan Berat Badan : - Definisi : akumulasi bobot tubuh sesuai dengan usia dan jenis kelamin - Ekspektasi : membaik						Intervensi Utama : - Edukasi berat badan efektif - Manajemen berat badan Intervensi Pendukung : - Dukungan kelompok - Edukasi diet - Konseling nutrisi - Limit setting - Manajemen cairan - Manajemen hiperglikemia - Manajemen hipoglikemia - Manajemen nutrisi - Manajemen perilaku - Manajemen cairan - Pemantauan nutrisi - Pemberian makanan - Pemberian makanan enteral - Penentuan tujuan bersama - Perawatan bayi - Promosi berat badan - Promosi koping - Promosi latihan fisik - Reduksi ansietas - Terapi aktivitas
	Memburuk	Cukup Memburuk	Sedang	Cukup membaik	Membaik	
Berat badan	1	2	3	4	5	
Tebel lipatan kulit	1	2	3	4	5	
Indeks masa tubuh	1	2	3	4	5	

	Manajemen Berat Badan Berlebih : Definisi : mengidentifikasi dan mengelola berat badan agar dalam rentang optimal. Tindakan Observasi : - Identifikasi kondisi kesehatan pasien yang dapat memengaruhi berat badan Terapeutik : - Hitung berat badan ideal pasien - Hitung persentase lemak dan otot pasien - Fasilitasi menentukan target berat badan yang realistis Edukasi : - Jelaskan hubungan antara asupan makanan, aktivitas fisik, penambahan berat badan dan penurunan berat badan - Jelaskan faktor risiko berat badan lebih dan berat badan kurang - Anjurkan mencatat berat badan setiap minggu, jika perlu - Anjurkan melakukan pencatatan asupan makan, aktivitas fisik dan perubahan berat badan
--	---

L. Diagnosa keperawatan : Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah

Luaran	Intervensi
- Luaran utama : kestabilan kadar glukosa darah - Luaran tambahan : Kontrol risiko, perilaku menurunkan berat badan, status antepartum, status intrapartum, status nutrisi, status pascapartum, tingkat pengetahuan Perilaku menurunkan berat badan : - Definisi : tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengurangi berat badan - Ekspektasi : meningkat	Intervensi utama : - Manajemen hiperglikemia - Manajemen hipoglikemia Intervensi pendukung : - Edukasi diet - Edukasi kesehatan edukasi latihan fisik - Edukasi proses penyakit - Identifikasi risiko - Konseling nutrisi

	Menu- run	Cukup Menur un	Seda ng	Cukup mening kat	Mening kat	
Menentukan target berat badan dalam rentang normal	1	2	3	4	5	- Manajemen medikasi - Manajemen teknologi kesehatan - Modifikasi perilaku - Keterampilan social - Pelibatan keluarga - Pemantauan nutrisi - Pemberian obat - Pemberian obat oral - Pemberian obat subkutan - Perawatan kehamilan risiko tinggi - Promosi berat badan - Promosi dukungan keluarga - Promosi kesadaran diri - Surveilans - Yoga Berikut ini merupakan contoh intervensi tambahan edukasi diet : Definisi : mengajarkan jumlah, jenis dan jadwal asupan makanan yang diprogramkan Tindakan Observasi : - Identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi - Identifikasi tingkat pengetahuan saat ini - Identifikasi kebiasaan pola makan saat ini dan masa lalu - Identifikasi persepsi pasien dan keluarga tentang diet yang diprogramkan - Identifikasi keterbatasan finansial untuk menyediakan makanan Terapeutik : - Persiapkan materi, media, dan alat peraga - Jadwalkan waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan kesehatan - Berikan kesempatan pasien dan keluarga bertanya - Sediakan rencana makan tertulis, jika perlu
Memiliki komitmen pada rencana makan yang sehat	1	2	3	4	5	
Menghindari makanan dan minuman tinggi kalori	1	2	3	4	5	
Memilih makanan dan minuman bergizi	1	2	3	4	5	
Memonitor IMT	1	2	3	4	5	

	Edukasi : - Jelaskan tujuan kepatuhan diet terhadap kesehatan - Informasikan makanan yang diperbolehkan dan dilarang - Informasikan kemungkinan interaksi obat dan makanan, jika perlu - Anjurkan mempertahankan posisi semi Fowler (30-40 derajat) 20-30 menit setelah makan - Anjurkan mengganti bahan makanan sesuai dengan diet yang diprogramkan - Anjurkan melakukan olahraga sesuai toleransi - Ajarkan membaca label dan memilih makanan yang sesuai - Ajarkan cara merencanakan makanan yang sesuai program - Rekomendasikan resep makanan yang sesuai dengan diet, jika perlu Kolaborasi : Rujuk ke ahli gizi dan sertakan keluarga, jika perlu
--	--

M. Implementasi

Implementasi keperawatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam menerapkan atau mengatualisasikan apa yang telah direncanakan (intervensi) guna mengatasi masalah kesehatan klien (Rahayu, dkk, 2022)

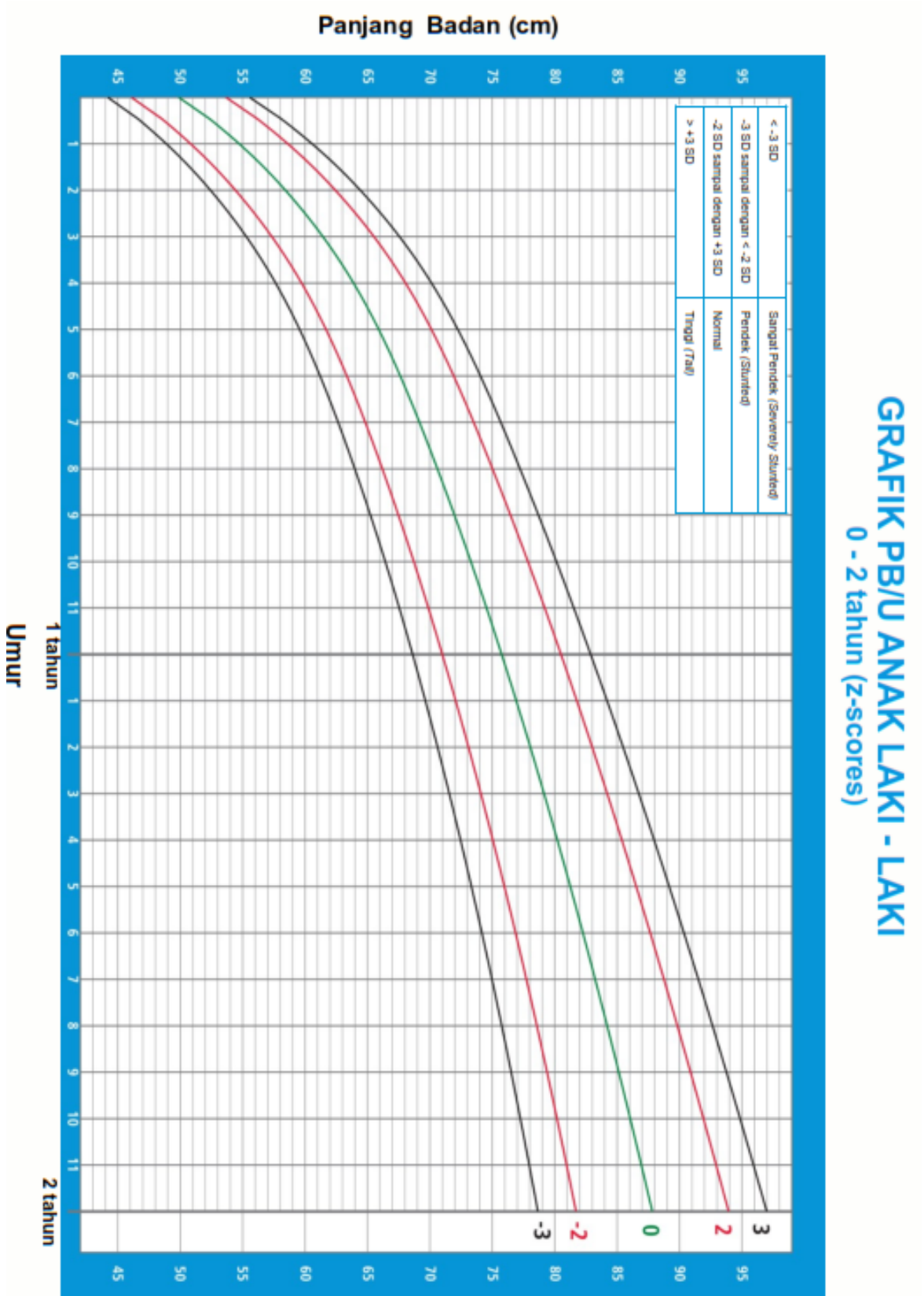
N. Evaluasi

Evaluasi keperawatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan perawat untuk menilai sejauh mana keberhasilan tindakan keperawatan berdasarkan indikator dan kriteria hasil yang ditetapkan (Rahayu, dkk, 2022).

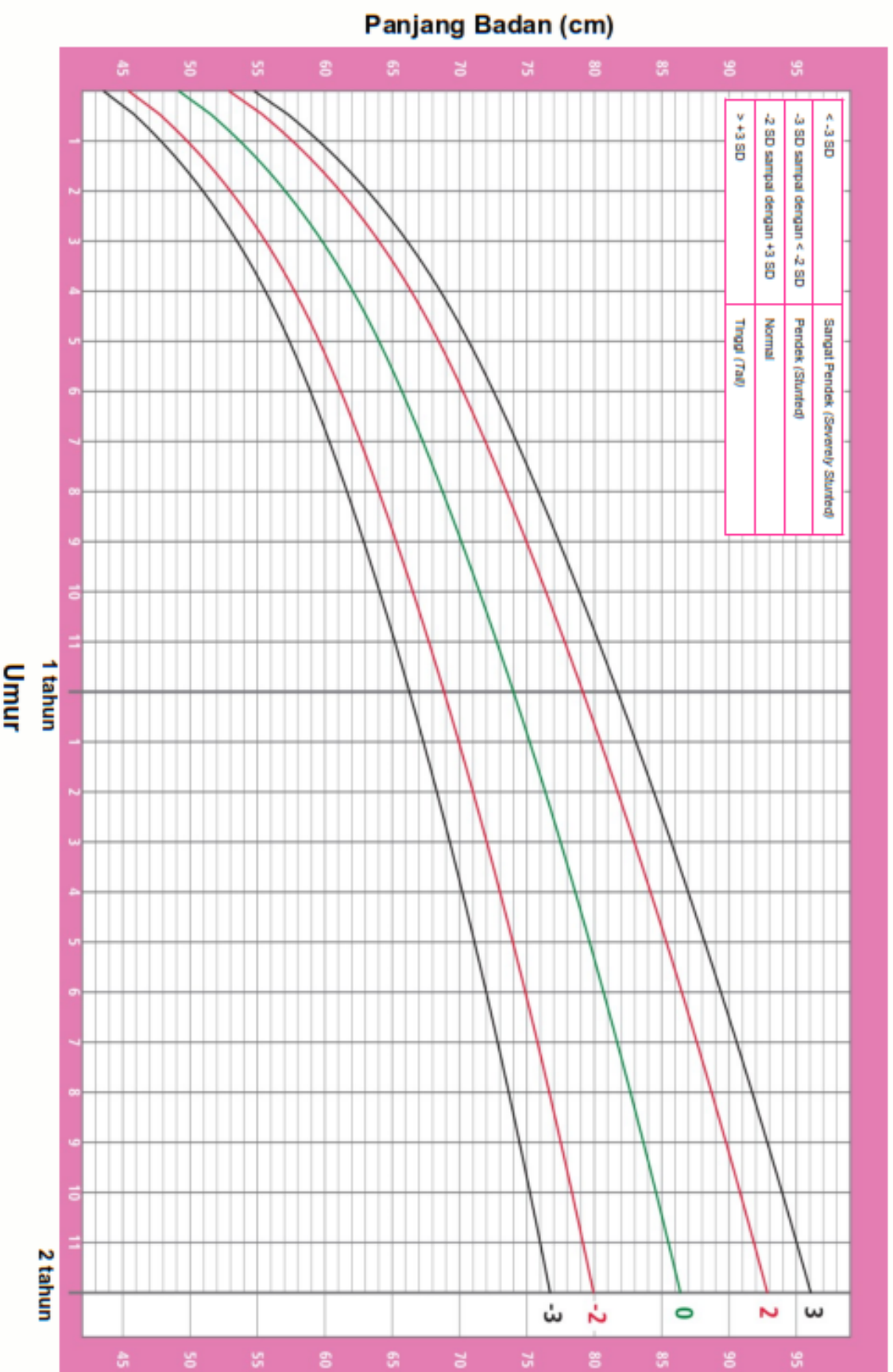
DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Yekti H. 2021. Patifisiologi Gizi : Regulasi Makan Gangguan Homeostatis Energi Peran Zat Gizi pada PERTumbuhan dan Perkembangan Otak. Bogor: Pt Penerbit IPB Press.
- Hastuti, Pramudji. 2019. *Genetika Obesitas*. . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kemenkes RI. (2020). *STANDAR ANTROPOMETRI ANAK*. 3, 1–78.
- Kemenkes RI. Laporan hasil riset kesehatan dasar Indonesia tahun 2018. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta: badan penelitian dan pengembangan kesehatan 2019: 2018
- Palupa W. 2014. Gizi Kesehatan Masyarakat. Jakarta: buku kedokteran EGC
- Rahayu, Sri, Suci, dkk. 2022. *Keperawatan Anak*. Sumatra Barat : Pt.Global Eksekutif Teknologi
- Susetyowati, Huriyati, Emy, Kandarina I., Faza F., 2019. *Peranan Gizi Dalam Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Tim pokja SDKI DPP PPNI, 2017. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Definisi Dan Indicator Diagnostik. Jakarta: PPNI
- Tim pokja SIKI DPP PPNI, 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Definisi Dan Tindakan Keperawatan. Jakarta: PPNI
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018. Standar Luaran Keperawatan Indonesia Definisi Dan Kriteria Hasil Keperawatan . Jakarta: PPNI

LAMPIRAN

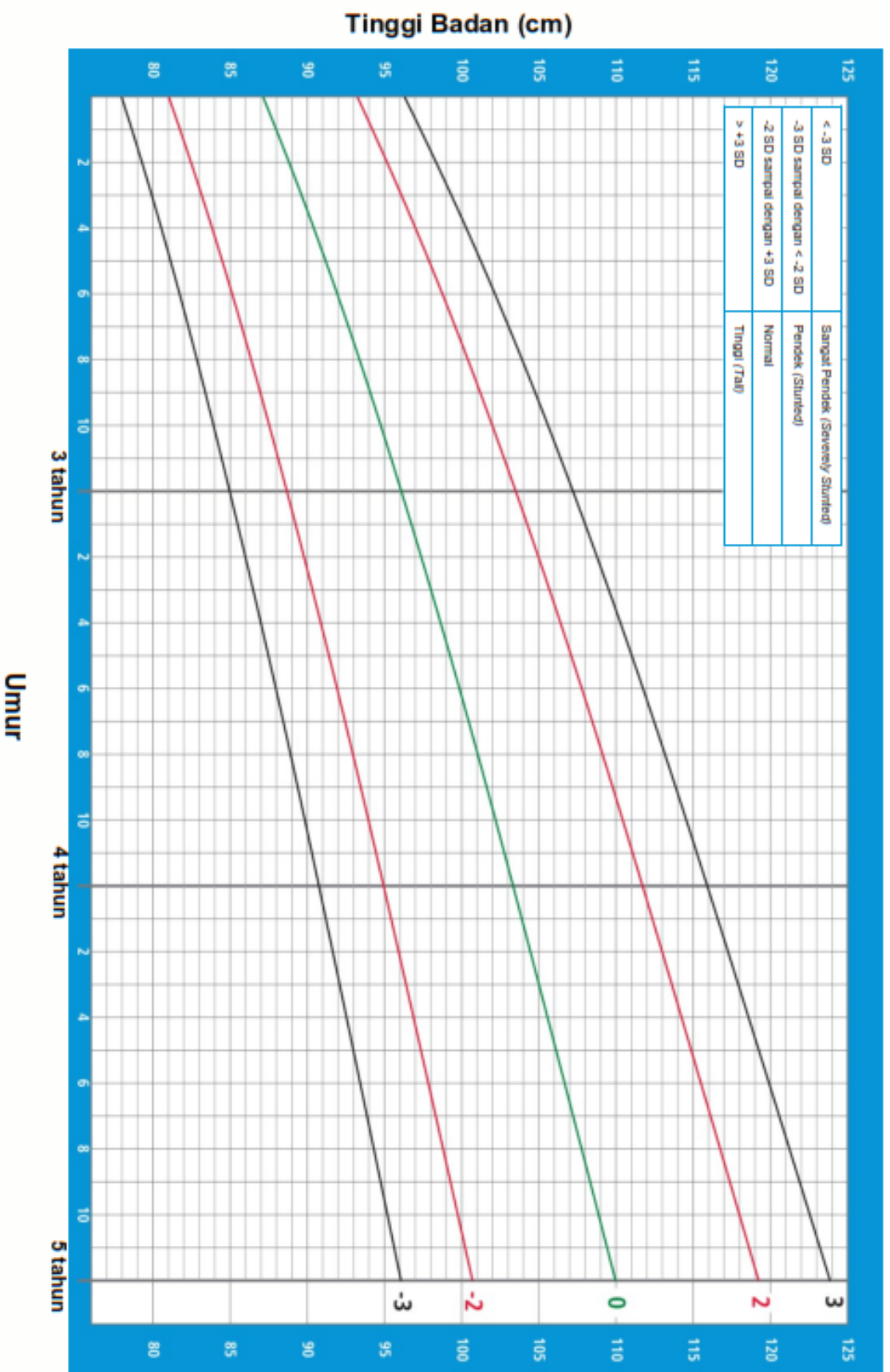


GRAFIK PB/U ANAK PEREMPUAN 0 - 2 tahun (z-scores)

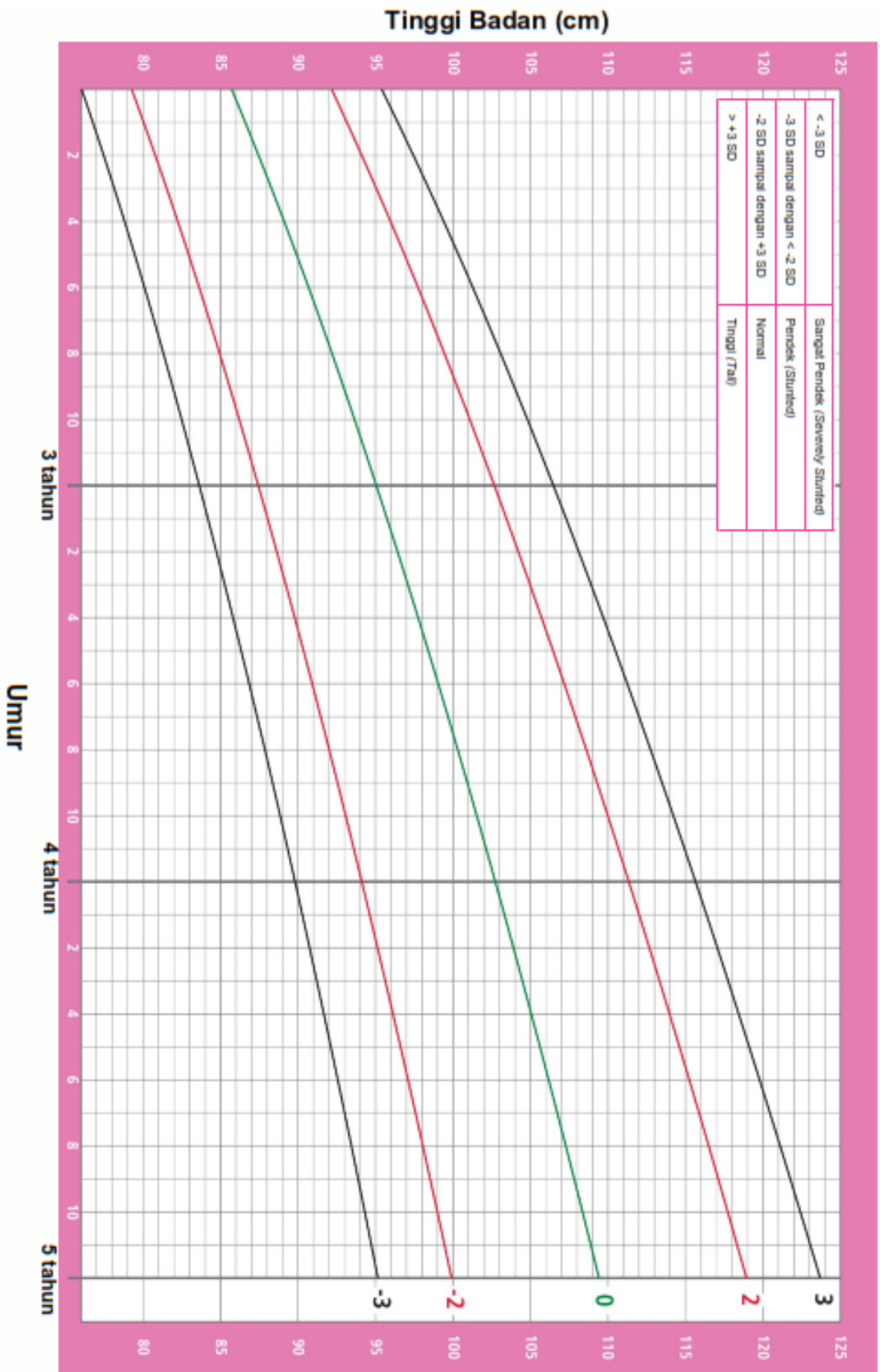


GRAFIK TB/U ANAK LAKI - LAKI

2 - 5 tahun (z-scores)



GRAFIK TB/U ANAK PEREMPUAN 2 - 5 tahun (z-scores)



BIOGRAFI PENULIS

Kadek Ayu Erika

Penulis lahir di Denpasar pada tahun 1977, lulus dari Akademi Keperawatan Departemen Kesehatan Ujung Pandang tahun 1999. Penulis mencapai gelar Sarjana Keperawatan tahun 2022 dan Ners tahun 2003 di Universitas Airlangga, Surabaya, menyelesaikan studi Master Biomedik Fisiologi tahun 2009 dan memperoleh gelar Doktor pada tahun 2014 di Prodi S3 Ilmu Kedokteran Unhas dengan konsentrasi disertasi bidang Keperawatan Anak.

Penulis adalah dosen Keperawatan Anak Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin Makassar sejak 2003 hingga sekarang dan sebagai koordinator keperawatan anak sejak 2003-2021. Penulis juga berperan aktif sebagai Ketua Ikatan Perawat Anak Indonesia (IPANI) Provinsi Sulawesi Selatan sejak 2017-2022 dan 2022-2027 serta pengurus pusat IPANI periode 2022-2027 dengan melakukan berbagai aktivitas pengembangan kompetensi perawat anak, bakti sosial, dan kegiatan lainnya yang berfokus pada keilmuan keperawatan anak.

Penulis aktif dalam pengajaran, pembimbingan, penguji tugas akhir pada mahasiswa S1, S2, dan S3 bidang keperawatan yang berfokus pada bidang keilmuan keperawatan anak yang terintegrasi dalam berbagai sistem, membimbing mahasiswa praktik profesi ners di rumah sakit maupun komunitas, aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan derajat kesehatan anak dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat.

Penulis juga sebagai pendamping mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) lolos pendanaan Nasional tahun 2021 dan sebagai penulis soal Uji Kompetensi (Ukom) Ners terbanyak Kedua Nasional tahun 2022. Penulis mendapatkan reward publikasi ilmiah dan lolos pendanaan hibah penelitian internal dan nasional serta telah menghasilkan karya ilmiah berupa buku, buklet, dan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari hasil karya sejak tahun 2017 hingga sekarang. Penulis juga aktif sebagai pemateri maupun peserta dalam berbagai kegiatan ilmiah seminar, workshop, dan pelatihan keperawatan anak serta hasil penelitian telah diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan dipresentasikan dalam konferens nasional dan internasional.

Kata Motivasi

Dengan cinta hidup menjadi indah. Dengan ilmu bermanfaat hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup menjadi terarah.

SINOPSIS

ASUHAN KEPERAWATAN ANAK DENGAN GANGGUAN NUTRISI

Dr. Kadek Ayu Erika, S.Kep.Ns.,M.Kes.

Ns. Tuti Asrianti Utami, S.Kep.,SE.,M.Kep.

Citra Setyo Dwi Andhini, S.Kep.,Ners.,M.Kep.

Buku asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi adalah buku yang berisi informasi lengkap tentang gangguan nutrisi yang lazim terjadi pada anak. Buku ini terdiri dari 3 bagian asuhan keperawatan yaitu : (1) Asuhan Keperawatan Anak Stunting, (2) Asuhan Keperawatan Anak Kekurangan Energi Protein (KEP), dan (3) Asuhan Keperawatan Anak Obesitas. Buku ini sangat menarik, mudah dipahami dan bermanfaat bagi tenaga kesehatan untuk dipelajari yang mencakup konsep dasar dan keperawatan yang dituliskan secara lengkap dengan sumber yang terupdate NANDA NOC NIC dan di padukan sumber buku 3S (SDKI, SLKI, SIKI). Buku ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian sebagai penerapan *evidence-based practice*. Buku ini diuraikan secara jelas dan sistematis yang memudahkan pembaca dalam memahami setiap gangguan nutrisi yang terjadi pada anak.

Buku asuhan keperawatan anak dengan gangguan nutrisi adalah buku yang berisi informasi lengkap tentang gangguan nutrisi yang lazim terjadi pada anak. Buku ini terdiri dari 3 bagian asuhan keperawatan yaitu : (1) Asuhan Keperawatan Anak Stunting, (2) Asuhan Keperawatan Anak Kekurangan Energi Protein (KEP), dan (3) Asuhan Keperawatan Anak Obesitas. Buku ini sangat menarik, mudah dipahami dan bermanfaat bagi tenaga kesehatan untuk dipelajari yang mencakup konsep dasar dan keperawatan yang dituliskan secara lengkap dengan sumber yang terupdate NANDA, NOC, NIC dan di padukan sumber buku 3S (SDKI, SLKI, SIKI). Buku ini juga dilengkapi dengan hasil penelitian sebagai penerapan evidence-based practice. Buku ini diuraikan secara jelas dan sistematis yang memudahkan pembaca dalam memahami setiap gangguan nutrisi yang terjadi pada anak.

ISBN 978-623-09-3098-0



Penerbit :
PT Nuansa Fajar Cemerlang
Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F
Jalan S. Parman Kav. 22-24
Kel. Palmerah, Kec. Palmerah
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480
Telp: (021) 29866919